行业 AI 书系 · 14

AI 睡眠手册

看懂睡眠数据、用好智能设备、睡回好觉



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 睡眠手册

看懂睡眠数据、用好智能设备、睡回好觉

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、几条约定 v
四、术语表 v
第 1 章 三亿人睡不好，钱先到了：AI 进卧室的这一年 1
本章导读 1
1.1 三亿人睡不好：数字从哪来，政策怎么接 1
1.2 钱已经到位：县医院在建睡眠中心 2
1.3 卧室里的标准化：国标、等级评定与补贴 3
1.4 AI 会替你睡觉吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十一条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会问比会买更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 9
2.3 四要素骨架：把睡眠问题说清楚 9
2.4 睡眠场景提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 数据红线：哪些内容别原样贴给 AI 11
第 3 章 看懂你的睡眠数据：手环、手表与 App 14
本章导读 14
3.1 你的手环在测什么：四类核心数据 14
3.2 用 AI 读数据：提示词与核验三步 15
3.3 数字焦虑：为什么越测越睡不好 15
3.4 消费级设备的边界：记录不是诊断 16
第 4 章 从床垫到睡眠中心：看懂一份监测报告 19
本章导读 19
4.1 家用监测：床垫和监测带测什么、测不准什么 19
4.2 医院的多导睡眠监测：睡眠中心里的那台机器 20
4.3 用 AI 预读医院报告：能做与不能做 20
4.4 就医信号清单：数据里的红旗 21
第 5 章 智能助眠产品怎么选：国标、等级与补贴 24
本章导读 24
5.1 两份新标准：国标与 L1-L4 等级怎么用 24
5.2 补贴怎么查：从深圳样本到你的城市 25
5.3 虚标识别法：宣传词对照表 25
5.4 一张选购决策表：需求、预算、标准对齐 26
第 6 章 AI 助眠应用与大模型：怎么挑、怎么测 28
本章导读 28
6.1 产业在做什么：从 T12 到 AI DREAM 28

6.2 四种类型：监测、陪伴、干预、大模型 29
6.3 五问评测框架：下载前先过一遍 29
6.4 让 AI 当你的评测助手 30
第 7 章 什么时候必须去医院：AI 的医疗边界 32
本章导读 32
7.1 AI 建议的三个可信度层级 32
7.2 必须就医的信号清单 33
7.3 睡眠门诊：怎么找、怎么看 33
7.4 就诊准备：用 AI 把病史讲清楚 34
第 8 章 睡眠产业的真钱在哪里：政策、政采与盘子 37
本章导读 37
8.1 盘子：5737 亿的总账怎么读 37
8.2 医疗侧：五单政采拆一条建设链路 38
8.3 消费侧：45 亿床垫与 90% 增速背后 38
8.4 机会地图：谁在这波里做什么 39
第 9 章 门店与药店：导购和店员的 AI 工作法 42
本章导读 42
9.1 导购的新功课：把标准讲成顾客听得懂的话 42
9.2 药店店员：白皮书点名的短板怎么补 43
9.3 用户教育内容：AI 批量生成的做法 43
9.4 一线合规话术清单：哪些话不能说 44
第 10 章 睡眠健康管理师：新职业的入行与进修 47
本章导读 47
10.1 一个新职业的现状：机会与不确定性 47
10.2 官方承认的缺口：医院在喊缺人 48
10.3 想入行怎么学：挑培训与 AI 辅助学习法 48
10.4 细分口：睡眠小城与康养文旅 49
第 11 章 底线与长期：数据隐私、合规与习惯 51
本章导读 51
11.1 最私密的数据：隐私三原则 51
11.2 合规两条线：非医疗建议与不写疗效 52
11.3 AI 依赖与睡眠卫生的回归 52
11.4 长期主义：记录、看懂、该就医时就医 53
附录 55
附录 A 高频提示词索引 55
附录 B 本书出现的工具与平台 55
参考文献与资料来源 56
一、政策文件与官方行动 56
二、政府采购公开记录（2026-05 ~ 2026-10） 57
三、行业资料与产业公开动作 57
四、课件素材（本书第 2 章改编来源，本地资产） 58
检索与写作说明 58

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-9 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 10-11 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

先说一个数字：全国有睡眠困扰的人超过 3 亿，18 岁以上人群的困扰率是 48.5%——这是 2026 年世界睡眠日（主题「优质睡眠 美好生活」）公开报道引用的口径。也就是说，翻开的读者里，可能一半人昨晚就没睡好。

但这不是又一本教你怎么睡的科普书。市面上讲睡眠方法的书已经不少（2024 到 2026 年，光我们检索到的科普书就有四本），这本书讲的是另一件事：**当 AI、传感器和大模型涌进卧室之后，一个普通人该怎么跟它们打交道。**

你可能刚买了一只手环，App 里「深睡 12%、浅睡 61%、快速眼动 20%」看得一头雾水；你可能被直播间种草了智能床垫，四五千到几万的价格，宣传词一个比一个玄；你可能下载了三四个睡眠 App，白噪音、睡前故事、AI 陪聊都试过，不知道哪个靠谱；你可能睡前刷手机看到「长期失眠会怎样怎样」，越看越不敢睡。

这些具体的事，就是本书的内容：手环数据怎么看、床垫宣传怎么拆、AI 的回答怎么核、什么情况该去医院、去医院之前怎么准备。AI 是贯穿全书的工具——我们教你用它读数据、拆宣传、做就诊准备，也反复提醒你它的边界：AI 给的建议分三层可信度，涉及诊断和治疗的，一律去找医生。

如果你是从业者，这本书也为你写了一部分：寝具门店导购、药店店员（行业白皮书点名了店员专业能力这个短板）、准备入行「睡眠健康管理师」这个新职业的人、康养与酒店的运营者。第 8 到第 10 章是你们的章节：产业里的真钱在哪、一线怎么用 AI 工作法、新职业的现状与入行路径。

二、这本书怎么用

全书 11 章，按「认知 → 数据 → 设备 → 边界 → 从业」的坡度排。两种读法：

普通读者（C 端）：第 1 章看个全景，可以快读；第 2 章是全书通用技能（提示词与数据红线），建议细读——后面每一章的提示词都建立在这章的骨架上；第 3、4 章对应你手上的设备与数据；第 5 章在买产品之前读，第 6 章在下 App 之前读；第 7 章最重要，讲什么时候必须去医院，建议所有人都读。第 11 章收尾，讲隐私与习惯。

从业者（B 端）：第 8 章看产业与政采全景；第 9 章给门店导购与药店店员；第 10 章给健康管理师学员与康养文旅运营者；第 9-11 章的合规红线两节，建议做培训的人单独抽出来讲。

「手头的事对哪一章」对照表：

你手头的事	直接翻
手环/手表的睡眠数据看不懂	第 3 章
拿到一份睡眠监测报告，想先看懂	第 4 章
打算买智能床垫/枕头/灯具	第 5 章
纠结下不下某个睡眠 App	第 6 章
AI 给的睡眠建议不知道能不能信	第 2 章第 2.2 节 + 第 7 章
睡不好很久了，犹豫要不要去医院	第 7 章
要去睡眠门诊，想准备一下	第 7 章第 7.4 节
门店导购/药店店员，要做用户教育	第 9 章
想了解睡眠健康管理师这个新职业	第 10 章
想看懂睡眠产业的钱从哪来	第 8 章
担心睡眠数据隐私	第 11 章

每章自包含：导读说明这章解决什么问题，正文给方法与提示词，动手练习让你当场做一遍，思考题帮你想清楚边界。提示词示例全部放在围栏代码块里，可以原样复制、改成你的情况再用。

三、几条约定

事实口径。书中行业数据与案例只来自公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的行业报告与媒体数据四类来源，全部标注出处；查证不到的细节，一律标注「待验证」或不写。每章末尾的参考文献列了原始来源，想深挖的按图索骥。

就医边界。这本书不提供医疗建议，也不能替代医生。书中提到的就医信号清单，来自医生公开科普中普遍列出的内容，仅作「提醒你去医院」的参考；诊断、治疗、用药，以医生的判断为准。睡眠门诊的事，交给睡眠门诊。

AI 边界。大模型会出错（第 2 章专门讲三类错误），书里所有「让 AI 帮你做什么」的方法，都配了对应的核验步骤。AI 出初稿，你做把关——这条立场贯穿全书，也是我们对「人机协同」四个字的全部理解。

关于标准与政策。标准在更新、政策在滚动，本书数据检索截至 2026 年 11 月 2 日。涉及你真金白银的决策（买产品、报培训、申请补贴），请以购买和申领当时的官方文件为准。

四、术语表

按出现顺序整理全书反复用到的概念。斜体部分为补充说明。

术语	一句话解释
睡眠经济	围绕睡眠质量的改善形成的产品与服务市场，覆盖家居寝具、监测设备、医疗服务、内容应用等环节；行业研究口径下 2025 年中国总盘约 5737 亿元
睡眠困扰	存在入睡困难、易醒、早醒、睡眠质量差等问题的状态；官方口径下 18 岁以上人群困扰率 48.5%
睡眠门诊	医院里专门诊治睡眠相关问题的门诊；国家卫健委 2025 年要求「每个地市至少一家医院提供心理门诊、睡眠门诊」
睡眠中心	医院内部成建制开展睡眠监测与诊疗的科室单元，通常配备多导睡眠监测等专用设备
多导睡眠监测（PSG）	在医院睡眠中心进行的整夜睡眠监测，记录脑电、眼动、呼吸、心率、血氧等多项指标，是睡眠障碍诊断的参考依据
睡眠结构	一夜睡眠的组成比例：深睡眠、浅睡眠与快速眼动睡眠各占多少
深睡眠	睡眠周期中修复作用突出的阶段，成年人通常占整夜睡眠的一到两成
快速眼动（REM）睡眠	与梦境记忆关系密切的睡眠阶段，一夜循环出现多次
睡眠周期	睡眠中深浅交替的循环单元，一个周期通常数十分钟，整夜循环数次
睡眠效率	实际睡眠时间占卧床时间的比例，睡眠报告常用指标
入睡潜伏期	从躺下准备睡觉到实际入睡的时长，过长常被视为入睡困难的信号
心率变异性（HRV）	相邻心跳间隔的波动程度，反映自主神经状态，是睡眠与压力监测的常用指标
血氧饱和度	血液中氧气含量占比；睡眠监测中持续走低可能与呼吸问题相关，需要医生判断
睡眠呼吸暂停	睡眠中呼吸反复暂停的病症，典型表现包括响亮鼾声与呼吸中断；就医信号清单的核心条目
失眠	入睡困难、维持困难或早醒并影响白天状态的睡眠障碍；长期失眠建议就医
认知行为疗法（CBT-I）	针对失眠的结构化非药物干预方法，医生公开科普中普遍将其列为慢性失眠的一线推荐之一
睡眠卫生	围绕作息规律、光线、咖啡因、卧室环境等基础习惯的做法集合；AI 睡眠建议中可信度相对较高的一层
智能床	内置传感器与调节机构的床具，可监测睡眠数据、调整角度或软硬；中国首个《智能床》国家标准 2025 年 8 月实施

术语	一句话解释
家具智能等级评定（L1-L4）	对家具智能化程度的分级评定标准，2026 年 3 月落地，L4 为最高等级
可穿戴设备	手环、手表等随身佩戴的监测设备，消费级睡眠监测的主力形态
二类医疗器械	需要注册审批、安全性有效性需加控制的医疗器械类别；部分睡眠监测类产品按此路径管理，具体以药品监督管理部门查询为准
睡眠大模型	面向睡眠场景训练或调优的垂直大模型，如公开报道中的慕思 T12
睡眠健康管理师	2025 年 7 月列入的国家新职业工种，培训认证体系起步中、全国统一制度尚未定型
数字焦虑	因持续查看睡眠数据产生的焦虑情绪；数据本该帮你睡觉，别让它帮你失眠
幻觉	大模型一本正经地编造不存在的事实或数据的错误倾向；用 AI 读睡眠报告前必须知道
提示词	发给 AI 的指令文本；本书所有实操的核心工具，四要素骨架见第 2 章
上下文	一次对话中 AI 能「记住」的内容长度上限；超长报告需要分段投喂
购新补贴	地方政府对购买新品类的财政补贴；智能床已进入多地补贴目录，深圳适老化焕新补贴比例 30%、单人最高 1 万元

本书数据检索截至 2026 年 11 月 2 日。各章引用来源见章末与 99-参考文献与资料来源。

第 1 章 三亿人睡不好，钱先到了：AI 进卧室的这一年

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么「睡眠」突然成了政策、产业和钱一起使劲的地方。不是因为它新鲜——睡不好的人一直很多；是因为三件事几乎同时发生了：文件——睡眠健康写进了国家行动方案，睡眠门诊成了卫健部门的硬任务；钱——县市级医院正在成建制地建睡眠中心，政府采购一笔接一笔；标准——智能床有了国标，家具有了智能等级评定，补贴进了地方目录。读完这章，你能看懂这场「睡眠热」的来龙去脉，知道自己所在城市的医院为什么在采购睡眠设备，能判断家里的手环和床垫正处在一个什么样的产业里，最后拿着全书的地图，知道自己该翻哪一章。

1.1 三亿人睡不好：数字从哪来，政策怎么接

先把数字摆出来。2026 年世界睡眠日的主题是「优质睡眠 美好生活」，公开报道引用的口径是：全国有睡眠困扰的人超过 3 亿，18 岁以上人群的困扰率达到 48.5%（来源：新华日报交汇点 2026 年 3 月 21 日报道）。

48.5% 这个数值得停下来想一下。它的意思是：把所有成年人排成一排，每两个里就有一个存在睡眠困扰。这不是少数人的问题，是多数人的日常。

问题攒得够大，政策就开始接。最近两年这条线上有四个动作，按时间排：

- 2025 年，国家卫健委把「每个地市至少一家医院提供心理门诊、睡眠门诊」列为为民服务八件实事之一——注意「每个地市」和「至少一家」这两个词，这是硬任务，不是倡议。
- 2025 年 4 月，全国爱卫办发布《睡眠健康核心信息及释义》，并做了委级在线访谈解读——科普有了官方版本。
- 2025 年 7 月，「睡眠健康管理师」列为国家新职业工种——服务睡眠的人，成了国家承认的职业（第 10 章细讲）。
- 《健康中国行动 2024—2026 年实施方案》把「睡眠健康促进」列为慢性病防控专项行动，国家卫健委推动各地设立睡眠门诊。

（来源：上述文件与报道见章末参考文献；新华日报交汇点、国家卫健委在线访谈等公开渠道）

这四个动作各管一段：门诊硬任务管「睡不着的人有地方看病」，核心信息管「大家先知道基本的对错」，新职业管「服务的人有队伍」，健康促进行动管「这事长期有人抓」。

对你个人，政策最实在的一条是门诊下沉。以前看睡眠问题，多数人想到的是大城市的三甲医院；现在每个地市至少要有一家医院设睡眠门诊，县市级医院也在跟进——第 1.2 节你会看到，跟进不只是开了个诊室，而是整批整批地买设备。

1.2 钱已经到位：县医院在建睡眠中心

政策是文件，钱是中标公告。2026 年 5 月到 10 月，公开渠道能查到的医院睡眠中心设备采购至少有 5 单，其中 3 单金额完整：

项目	金额	中标时间
新疆疏勒县医院睡眠中心设备采购	中标 293 万元+（明细部分打码）	2026-09-17
诸城市人民医院睡眠中心设备采购	中标 170.39 万元	2026-10-10
望江县医院睡眠中心建设设备采购	中标 140 万元	2026-08-12
陇南市武都区中心医院睡眠中心设备采购	中标 103.56 万元	2026-06-24
宜昌某医院睡眠中心设备采购	金额公告中打码	2026-05-08

（来源：中国政府采购网及各地公共资源交易平台公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-10 月；金额完整的 3 单合计约 607 万元）

这张表有三个读法。

看地点。疏勒县、诸城、望江县、陇南武都区——没有一个是省会或一线城市，全是县级和地市级。这说明「每个地市至少一家睡眠门诊」的硬任务已经传导到了基层：不是文件里写着，是县医院真金白银在买设备。

看金额。单笔 100 万到 300 万的量级。买什么？疏勒县的采购清单里有 11 类设备：重复经颅磁刺激仪、睡眠呼吸初筛仪、多导睡眠记录仪、脑电治疗仪、心理沙盘等；陇南的单子里有多导睡眠测量仪、便携睡眠监测仪。这些名字现在可能很陌生，第 4 章会带你认识其中最重要的几台——认识它们，你去医院做检查时心里有数。

看节奏。5 月宜昌、6 月陇南、8 月望江、9 月疏勒、10 月诸城——半年五单，月月有。这不是某一地的突击，是一条稳定跑量的建设线。

这条建设线对你意味着两件事。一是「看睡眠门诊」正在从大城市的事变成家门口的事，你所在的地市大概率已经有一家医院在认真做睡眠诊疗了。二是设备和数据会越攒越

多——县医院建起了睡眠中心，就意味着多导睡眠报告会在更多普通人手里出现，而看懂报告这件事，正是本书第二部分（第 3、4 章）要教的。

1.3 卧室里的标准化：国标、等级评定与补贴

医院在往前跑，卧室这头也在变。变化的关键词是「标准化」——野蛮生长的阶段要过去了。

两份标准先看时间线：中国首个《智能床》国家标准 2025 年 8 月实施，舒达是主要起草单位之一；家具智能等级评定标准（L1-L4）2026 年 3 月落地，把家具的智能化程度分成四档（来源：中国质量新闻网 2026 年 9 月报道）。这两份标准的意义，对消费者来说就一句话：以后判断一张床「智能到什么程度」，可以对着标准和等级说事，而不是听导购的形容词。第 5 章会专门教你怎么用。

补贴跟上来了。智能床已经进入多地购新补贴：深圳 2025 年的适老化焕新行动，把睡眠监测产品纳入 30% 补贴、单人最高 1 万元；更大的背景是智能床首次进入国家级「两新」补贴目录表述下的地方购新补贴（来源：央广网 2026 年 9 月 24 日报道）。深圳还有一个更大的盘子——AI 终端行动计划（2025-2026）提出 2026 年产业规模 8000 亿元、60 个典型应用场景，智慧养老（睡眠是重要场景）在列（来源：中国经营网报道）。

标准管「什么是好」，补贴管「买得起」，中间还夹着一个快速膨胀的市场：智能床垫 2026 年约 45 亿元的盘子，科技助眠品类同比增速 90%（尚普咨询/艾媒咨询口径，转引自中国质量新闻网报道）。

产业侧的头部动作也密集。慕思牵头组建东莞市数字人体与智慧睡眠创新联合体，2026 年 7 月揭牌，睡眠垂类大模型 T12 在联合体落地，联合了华南理工、北航、北大三院等机构；慕思 2026 年上半年 AI 产品收入 2.36 亿元，同比增 95.69%（华安证券研报口径）；喜临门直接把公司更名——「健康睡眠科技」，并与清华共建联合研究中心；舒达把 AI 做成了独立品牌 AI DREAM（来源：新华网家居 2026 年 7 月 27 日报道、东方财富研报页等，详见章末）。

把全行业合起来看：行业研究口径下，睡眠经济 2025 年总盘约 5737 亿元（艾媒咨询）。医院在建中心，卧室在换标准，头部厂商在训大模型——三件事指向同一个判断：睡眠这个老问题，正在被当成一个正经产业来做。而你手里的手环、床垫、App，都站在这个产业的消费端。

1.4 AI 会替你睡觉吗：人机协同的基本立场

设备越来越聪明，大模型越来越能聊，一个自然的问题冒出来：AI 能不能直接替我把觉睡了？

不能。睡眠是生理过程，没有任何技术能替代它。但 AI 确实能在睡眠这件事上帮上忙——帮在信息和整理这一层。

这本书的立场一句话：**AI 管数据整理与初筛建议，人管生活习惯与就医决策。**

拆开看，睡眠这件事里，「信息整理」和「生活决策」各是什么。

AI 适合接的活：把手环一周的数据整理成一段人话；把一份布满术语的睡眠报告翻译成你能读懂的摘要；把医生没来得及细说的检查项目查个大概，帮你列就诊要问的问题；把一张床垫宣传页拆成「有标准支撑的」和「自说自话的」两栏。特征是：信息量大、重复性强、错了能看出来。

必须你自己做的活：换枕头、调作息、少刷手机——习惯的改变没有任何 AI 能替你执行；判断「我这种情况要不要去医院」——这是健康决策，AI 只能提供参考信息，决定和签字的必须是你和医生；花几千上万元买设备——预算是你的，需求也是你的。

往后每一章的方法都建立在这个分工上：AI 是你的数据分析员和资料秘书，不是你的医生，更不是替你睡觉的人。哪一章讲「让 AI 做什么」，哪一章就会同时讲「怎么核验它做的对不对」。

1.5 这本书的地图：十一条路，按需取用

全书 11 章，按「认知 → 数据 → 设备 → 边界 → 从业」的坡度排成四段。



图 1-4 全书 11 章四段地图：看清全局→看懂数据→用好设备与守住边界→从业与产业

第一部分（第 1-2 章）看清全局、打好底座：这一章给你产业与政策的全景；第 2 章给全书的通用技能——提示词与数据红线，后面每一章的实操都建立在它上面，建议所有读者细读。

第二部分（第 3-4 章）看懂数据：手环手表上的数据、床垫与医院报告里的数据，两级监测逐层读透，配全套 AI 解读提示词与核验方法。

第三部分（第 5-7 章）用好设备、守住边界：买产品之前读第 5 章（标准、补贴、避坑），下 App 之前读第 6 章（评测框架），第 7 章讲 AI 的医疗边界与就医信号——全书最重要的一章，建议所有读者都读。

第四部分（第 8-11 章）从业与产业：政采与盘子、门店药店工作法、健康管理师新职业、隐私合规与习惯。普通读者可以把这四章当「行业透视」，从业者当工作手册。

两条用法。有整块时间，就从第 1 章顺读到第 11 章；手头有事（看不懂数据、要买床、犹豫要不要去医院），直接翻对应章——前言第二节有「手头的事对哪一章」对照表，每章自包含。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的行业报告与媒体数据、产业公开动作的公开报道，全部标注出处；查证不到的细节，我们一律标「待验证」或者干脆不写。涉及健康判断的内容，本书只提供「提醒你去医院」级别的信号参考，不提供任何医疗建议——这条边界，第 7 章会用整整一章讲清楚为什么。

动手练习

这一章的练习不用写提示词，是「看懂你所在城市的睡眠资源」。步骤：

1. 打开地图或本地生活类应用，搜索「你所在城市的名字 + 睡眠门诊」或「睡眠医学中心」。记下：有没有结果？在哪家医院？
2. 再搜一次「你所在城市 + 多导睡眠监测」或「睡眠监测 睡眠中心」。对比两次结果：能做整夜监测的医院，通常就是当地睡眠诊疗的主力。
3. 打开中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），在搜索框输入「睡眠中心 设备采购」，把时间范围调到最近一年。看看有没有你所在省份的医院中标记录——本章表格里的 5 单分布在新疆、山东、安徽、甘肃、湖北，你的省份可能也有一单。
4. 把查到的医院名记下来。如果哪天你需要睡眠门诊（第 7 章会讲哪些信号该去），这就是你的第一份候选清单；用不上，也让你知道家门口的医疗资源在发生什么变化。

思考题

1. 「每个地市至少一家医院提供睡眠门诊」被列为卫健委为民服务八件实事之一。结合 1.2 节的政采表格（县市级医院为主、单笔 100-300 万元），说说「硬任务」和「倡议」的区别体现在哪里？
2. 智能床垫市场约 45 亿元、增速 90%，而医院睡眠中心政采半年 5 单、合计约 607 万元。两个数字量级差很大，为什么本章说「钱面最实的政采在医疗侧」？（提示：想想预算的性质——分散的个人消费 vs 成建制的机构采购。）
3. 1.4 节说「AI 管数据整理与初筛建议，人管生活习惯与就医决策」。举一个你自己的生活场景，说明哪部分可以交给 AI、哪部分必须你自己来。
4. 书里反复出现「待验证」这个标注（比如睡眠健康管理师的全国统一认证制度）。你觉得一本书对查不到的数据如实标注，比把它写成确定的结论，好处在哪里？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你所在城市的睡眠门诊查清楚——它会在第 7 章的就医准备练习里直接用上。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2024-2026 政策时间线：健康中国行动睡眠健康促进专项 → 卫健委门诊硬任务（2025）→ 《睡眠健康核心信息及释义》（2025-04）→ 睡眠健康管理师新职业（2025-07）→ 智能床国标（2025-08）→ L1-L4 等级评定（2026-03）	自绘
图 1-2	数据图	五单医院睡眠中心政采条形图（疏勒 293 万+、诸城 170.39 万、望江 140 万、陇南 103.56 万、宜昌金额打码）	自绘（数据源：政府采购公开中标公告）
图 1-3	示意图	睡眠产业三线图：医疗线（门诊硬任务→睡眠中心建设）、消费线（智能床垫 45 亿/增速 90%/补贴）、技术线（T12 大模型/喜临门清华/AI DREAM），交汇处标「5737 亿总盘（2025，艾媒）」	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-4	示意图	全书 11 章四段地图（看清全局→看懂数据→用好设备与守住边界→从业与产业）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会问比会买更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲普通用户必须知道的三条边界和一个核心技能。三条边界是幻觉、知识时效、上下文长度——它们决定了 AI 的回答什么时候能信、什么时候要打折；核心技能是提示词——你发给 AI 的那段指令，写得好坏直接决定回答质量。本章给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，配三个睡眠场景的完整可复制示例（解读睡眠报告初稿、整理睡眠日记、生成就诊提问清单），再教你把成功的提问沉淀成自己的模板库。最后是一条本章独有的红线：睡眠数据是最私密的个人健康信息，哪些内容不该原样贴给 AI、怎么脱敏。读完你能完成一次完整的「下指令→核验→迭代」循环，这本书后面每一章的实操都建立在这一章之上。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

先把工具认识一下。你现在能随手用到的 AI，绝大多数是「大语言模型」——一种在海量文本上训练出来的程序，你用自然语言跟它对话，它生成回答。国内的 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问，国外的 ChatGPT 等，都是这一类。它们已经做进了手机应用、网页、甚至你手环厂商的 App 里。

作为使用者，你不需要懂它的训练原理，但需要懂它的三个特性，因为它们直接决定你该怎么用：

一是它会「续写」而不是「查资料」。大模型生成回答的方式，本质上是根据你说的话，推算接下来最可能出现什么内容。这意味着它的回答读起来永远很流畅——哪怕在编。

二是它不知道「你」。你没告诉它的，它不知道；这个月的你跟上周的它，不共享记忆（除非应用做了记忆功能，而且你检查过它的设置）。

三是它对「可信来源」没有天然的鉴别力。你问它睡眠问题，它会把训练数据里见过的各种说法混在一起，权威科普和营销软文在它眼里可能没有区别——除非你在提示词里教它区分。

懂到这个程度就够用了。剩下的三条边界，才是真正决定你会不会用砸的地方。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

第一条：幻觉——大模型一本正经地编造不存在的事实或数据的错误倾向。

睡眠场景里，幻觉最危险的表现是编数据和编研究。你问「褪黑素对失眠有效吗，有没有研究支持」，它可能给你引一项听起来很具体的研究——作者、年份、期刊都有模有样，但那项研究可能根本不存在。消费级设备领域更常见：你问某款手环的「深睡监测准确率」，它可能报一个精确到小数点的百分比，而厂商和检测机构从未发布过这个数字。

对付幻觉只有一招：**凡是具体的数字、研究、结论，都要求它给出来源，然后你自己核**。核不出来源的，当它没说过。

第二条：知识时效——大模型的知识有截止日期，之后发生的事它不知道。

这条边界在睡眠领域特别要紧，因为这个领域的新东西出现得快：智能床国家标准 2025 年 8 月才实施，家具智能等级评定 2026 年 3 月才落地，慕思的睡眠大模型 T12 是 2026 年 7 月揭牌的联合体里落地的。你拿「智能床有什么国家标准」去问一个知识截止在 2024 年的模型，它很可能告诉你「还没有专门国标」——在它知道的世界里这是真话，在现实里已经过时了。

对策：涉及「最新」「现在」的问题（新标准、新产品、新政策），主动补背景——把你知道的文件名和时间告诉它，让它基于你给的信息回答；或者确认你用的模型有联网搜索功能并且开了。

第三条：上下文长度——一次对话里 AI 能「记住」的内容是有限的。

你想把一份几页的多导睡眠报告全文贴给它解读，可能贴不下，或者贴进去后面部分被「挤出」了它的记忆。多轮对话也一样：聊到第三四十轮，它可能忘了你开头说过的关键情况。

对策：长报告先做结构化提取（自己或让它帮你摘出关键数字，做成一张小表），分次投喂；重要背景（年龄、基础情况）在关键追问前重申一遍。

2.3 四要素骨架：把睡眠问题说清楚

把话说清楚，有一个够用的骨架，四要素：**角色、任务、背景、要求**。

- **角色**：让 AI 扮演谁。角色决定它的语言风格和知识侧重。「你是一位擅长向普通人解释医学检查报告的医生朋友」和「你是一位数据分析师」，对同一份数据会给出完全不同口吻的回答。
- **任务**：让它做什么。动词开头，一句话说清：「解读」「整理」「列清单」「核对」。任务越具体，回答越不飘。「帮我看看睡眠数据」是坏任务；「解读下面这 7 天的睡眠时长和深睡比例数据，指出趋势」是好任务。
- **背景**：把你的情况告诉它。年龄区间、作息习惯、困扰了多久、手上的设备——这些不写，它只能给通用答案；写了，它才可能贴着你的情况说。背景也是你控制隐私的阀门，下一节细讲。

- 要求：规定输出形式和边界。「300 字以内」「分条」「指出哪些信息你不掌握、需要医生判断」「不要给诊断结论」——要求里最重要的一条永远是：让它声明自己的局限。

四要素不用每次都写全，但拿不准的时候，全写一遍总不会错。下面三个模板就是按这个骨架搭的。

2.4 睡眠场景提示词模板：先抄、再改、后存档

模板一：解读手环睡眠周报。适合第 3 章的场景，先在这里建立用法。

```
你是一位擅长把健康数据讲成普通人能听懂的话的助手。请解读我下面这份睡眠
周报（来自消费级手环，数据仅供生活参考，不是医学诊断）：

【背景】我，三十多岁，上班族，长期 23:30 左右上床，用手环记录睡眠约半年。
【数据】
- 周一：总时长 6h10m，深睡 14%，入睡 40 分钟
- 周二：总时长 7h05m，深睡 17%，入睡 15 分钟
- 周三：总时长 5h50m，深睡 12%，入睡 55 分钟
- 周四：总时长 6h40m，深睡 16%，入睡 20 分钟
- 周五：总时长 5h35m，深睡 11%，入睡 60 分钟
- 周六：总时长 8h20m，深睡 19%，入睡 12 分钟
- 周日：总时长 7h50m，深睡 18%，入睡 18 分钟

【任务】1）用一句话概括本周整体情况；2）指出最值得注意的 1–2 个趋势；
3）给 2 条改善入睡时间的具体建议。
【要求】300 字以内；明确说明「手环数据有误差，趋势比单日值更可靠」；
不要给出任何诊断结论；如果有需要医生评估的情况，请直说「建议就医咨询」。
```

模板二：整理睡眠日记。医生问诊时最爱问「最近睡得怎么样」，多数人答不上来。让 AI 帮你把零散记录整理成结构化日记（第 7 章就诊准备会直接用到）。

```
你是一位睡眠健康管理助手。请把我下面这些零散的记录，整理成一份结构化的
两周睡眠日记表格。

【背景】我在准备去睡眠门诊就诊（第 7 章场景），医生需要了解我近期的睡眠模式。
【原始记录】（把你随手记的几行贴进来，例如：）
- 11/1 很晚才睡着，大概两点，刷手机
- 11/2 睡了 6 小时，白天很困，喝了三杯咖啡
- 11/3 中午补觉 1 小时，晚上反而睡不着
- ……

【任务】整理成表格：日期 / 上床时间 / 大致入睡时间 / 起床时间 / 白天补觉 /
咖啡因摄入 / 睡前活动 / 主观感受。缺失的字段标「未记录」，不要编造。
【要求】表格输出；末尾用 3 条以内总结「可让医生快速看到的模式」；
所有推断标注「推测」；不给诊断。
```

模板三：拆解一张产品宣传页。第 5 章选购避坑的预热。

```
你是一位帮消费者核对产品宣传的助手。下面是我从某智能床垫宣传页摘录的
文案，请逐条分析。

【文案】（逐条摘录宣传词，例如：）
1. 「AI 智能深睡算法，深睡提升 40%」
2. 「医护级睡眠监测」
3. 「获得XX认证」（把认证名称原样贴上）

【任务】对每条宣传词回答：1）这个说法属于哪一类（有标准可查 / 有公开数据
可查 / 纯宣传话术）；2）消费者应该怎么核实它；3）有没有暗示医疗功效的
风险表述。
【要求】用表格输出三栏：宣传词 / 分类 / 核实方法；最后提醒我哪些说法
如果商家无法出示依据，就应按「未经证实」对待。
```

三个模板的用法规则：**先抄**——原样发出去看结果；**再改**——把背景和数据换成你的（注意脱敏，下一节），看回答变化；**后存档**——哪次回答得最好，就把那条提示词存进你的备忘录或笔记应用，注明使用场景。三次之后，你就有了一个开始长大的个人提示词库。

存档时给模板加一行「核验记录」：这次 AI 的回答里我核实了什么、发现了什么错。核验记录比模板本身更值钱——它是你自己的错误样本库。

2.5 数据红线：哪些内容别原样贴给 AI

睡眠数据连着你的人和你的生活。它能推断出你的作息规律、健康状况，配合姓名和位置信息，甚至能定位到你这个人。用 AI 处理睡眠数据之前，三条红线先立好。

红线一：身份信息不上传。姓名、手机号、家庭住址、身份证号，任何场景都不需要贴给 AI。提示词里写「我，三十多岁，上班族」就够了，不需要「我，王小明，朝阳区 XX 路」。设备品牌和型号可写可不写——写型号能帮 AI 判断数据类型，但也让数据更可关联，自己权衡。

红线二：能脱敏就不裸传。睡眠时长、入睡时间这类数据，敏感度相对低，整理成表格投喂没问题（模板一就是这么做的）；但心率变异性、血氧这类健康指标，建议只给趋势和区间（「近两周血氧最低值在 90-93% 之间」），不必导出原始逐秒数据。原始数据里往往有你意想不到的信息。

红线三：分得清「通用问题」和「我的问题」。「深睡比例一般是多少」是通用问题，不含个人信息，随便问；「我深睡只有 10% 是不是有病」带着你的具体情况，问的时候就要意识到：你在向一家商业公司的服务器描述自己的健康状况。通用规律问 AI，具体判断问医生——这个分流原则，第 7 章还会展开。

一条实用建议：主流大模型应用都有「对话记录管理」设置，花五分钟找到它，看看你的历史对话保存在哪、能不能删除。知道数据去哪、怎么删，比事后焦虑有用得多。第 11 章还会回到隐私这个话题，把它变成一套完整的习惯。

动手练习

用本章模板一，完成一次完整的「下指令→核验→迭代」循环。步骤：

1. 打开任一国产大模型应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把本章模板一原样复制发送（数据是我编的示例周报，正好用来练手，不涉及你的隐私）。检查回答是否遵守了【要求】：有没有给诊断结论？有没有说明手环数据的局限？
3. 核验一轮：对回答里的每个具体数字和说法，问自己「这个有依据吗」。然后追加一句：「你上面提到的『深睡比例低于 15% 属于偏少』，这个标准有公开来源吗？」观察它怎么回答——如果它开始含糊其辞或继续引用来路不明的「标准」，你就亲眼见到了幻觉的样子。
4. 迭代一轮：把模板一里的数据换成你自己手环的真实一周数据（记得红线：不带姓名地址），发送后对比两次回答的差异。把你觉得最顺手的那版提示词存档，并记一行核验记录。

思考题

1. 「幻觉、时效、上下文」三条边界，各举一个睡眠场景里可能让你吃亏的具体例子（不限于本章出现过的）。
2. 模板一的【要求】里写着「不要给出任何诊断结论」。有人觉得多余——「我又不会信」。结合第 7 章预告的就医边界，说说这行字真正的防的是什么？
3. 四要素骨架里，「背景」既是让回答贴合你的关键，也是泄露隐私的入口。列出你打算写进背景的三样信息和打算隐去的三样信息。
4. 「通用规律问 AI，具体判断问医生」这个分流原则，用你自己的一个睡眠困扰检验一下：它属于哪一类？如果是混合的，怎么拆？
5. 动手实操：完成 2.6 节的四步练习，把你存档的提示词和核验记录带到第 3 章——那里马上要用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素结构图：角色（扮演谁）/ 任务（做什么）/ 背景（我的情况）/ 要求（输出形式与边界），中心标「核验」	自绘
图 2-2	流程图	「下指令→核验→迭代」循环图：发送提示词 → 逐条核对回答 → 标记存疑处 → 追问或改写 → 存档模板与核验记录	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-3	示意图	数据脱敏示意：左侧「可投喂」（时长/入睡时间表格、趋势区间），右侧「不上传」（姓名住址、逐秒原始数据），中间阀门标「身份信息」	自绘

第 3 章 看懂你的睡眠数据：手环、手表与 App

本章导读

手环和手表是目前离普通人最近的睡眠监测设备——第 1 章说过，睡眠困扰的人群超过 3 亿，而这 3 亿人里买了可穿戴设备的不在少数。但多数人看 App 只看两样：一个总时长，一个分数。深睡浅睡、心率变异性、血氧曲线，要么跳过，要么越看越慌。这一章带你把四类核心数据逐个读透，每类配一个 AI 解读提示词与核验方法；再用一节直面「数字焦虑」——为什么有人越测越睡不好，数据该看趋势还是看单日；最后讲清消费级设备的边界：它是记录工具，不是诊断工具。读完你能看懂自己 App 的睡眠页，让数据帮上忙而不是添堵。

3.1 你的手环在测什么：四类核心数据

不同品牌的 App 界面五花八门，但底层监测的就四类数据。认出它们，任何品牌的 App 你都能看懂个七八成。

第一类：睡眠时长与结构。时长好理解——睡了几个小时。结构是重点：你的 App 会把一夜睡眠切成几段，标注深睡眠、浅睡眠、快速眼动（REM）睡眠。按医生公开科普的通行说法，成年人的睡眠是周期性循环的：一个周期数十分钟，整夜循环数次，深睡眠通常占一到两成，REM 睡眠与梦境和记忆加工关系密切。手环靠心率与体动等信息「推测」你处在哪个阶段——注意「推测」这个词，后面 3.4 节会回头说它。

第二类：心率与心率变异性（HRV）。夜间静息心率反映身体的基础状态；HRV 是相邻心跳间隔的波动程度，反映自主神经的紧张与放松状态。多数 App 会给你夜间平均心率和一个 HRV 数值。这两个数个体差异极大——你的「正常」只有跟你自己的历史比才有意义。

第三类：血氧饱和度。部分手环支持夜间血氧监测。医生公开科普中，睡眠期间血氧持续走低可能与呼吸问题相关——这也是手环数据里少数值得认真对待的指标。但消费级设备的血氧读数受佩戴松紧、肤色、手腕姿势影响不小，单次偏低不用慌，反复出现的模式才值得留意。

第四类：综合评分。 App 把上述数据加权成一个分数（80 分、92 分之类）。分数便于坚持习惯，但要清楚：各家算法权重不同，90 分和 85 分之间没有可比的标准答案，跨品牌比较分数没有意义。

一句话总结四类数据的分量：结构看趋势，心率看自己，血氧看模式，分数别较真。

3.2 用 AI 读数据：提示词与核验三步

数据认识了，接下来让 AI 帮你把它读成结论。第 2 章的模板一（睡眠周报解读）就是为这一节准备的，这里不再重复模板本身，只讲流程与核验。

投喂前的整理。从 App 里导出或手动抄录你最近一两周的每日数据，做成第 2 章模板一那样的极简表格：日期、总时长、深睡占比、入睡耗时。三四个字段就够——字段越多，AI 越容易在细节上出错，你也越难核验。脱敏红线照旧：不带姓名住址，健康指标只给区间和趋势。

核验三步。AI 给出解读后，按顺序过三步：

第一步，**核对事实。**它说「你的深睡比例一周里有三天低于 15%」——回表格里数一数，是不是真的三天。事实层错了，后面的分析全作废。

第二步，**追问依据。**它说「深睡比例偏低可能影响恢复」这类判断时，追加一句：「这个说法的依据是什么？是普遍共识还是个别研究？」健康的回答会告诉你这是通行科普口径还是尚无定论；直接甩出一个精确「标准值」而不给出处的，存疑。

第三步，**查它没说什么。**好解读与坏解读的差别，往往在它有没有声明局限。回答里没有「手环数据有误差」「这不构成医疗建议」这类话的，让它补上；补不出来的，说明这个模型对健康话题的分寸感不够，换个场合少问它。

三步走完，你会得到一段自己看得懂、也敢信的周度小结。把它存下来——连续四周，你就有了自己的睡眠基线，这比任何 App 的评分都有用。

3.3 数字焦虑：为什么越测越睡不好

数据用对了是帮手，用错了是负担。近年医生和研究者公开讨论过一个现象：有人因为过度关注睡眠数据而焦虑，焦虑又反过来破坏睡眠——越盯着深睡比例，越睡不着。这个词在英文讨论里叫 orthosomnia，可理解为「睡眠数据完美主义」，中文语境常称「数字焦虑」。它不在你的手环说明书里，但它是可穿戴时代真实的新问题。

自查三个信号，命中就要调整用法了：睡前和起床第一件事都是看睡眠分数；某天分数低，一整天情绪都受影响；开始为了「数据好看」改变行为，比如明明不困也早早上床躺着凑时长。

调整的方向不是扔掉手环，是改看数据的方式。三条：

看趋势，不看单日。单晚数据受太多偶然因素影响（喝酒、睡前争吵、换了房间），没有任何一天的数字值得你焦虑。趋势是两周以上的走向——本章 3.2 节的方法做出来的周度小结，天然就是趋势视角。

数据服务生活，不是生活服务数据。数据的价值是让你发现「周三睡得差，因为晚上喝了咖啡」这种联系，然后调整行为。如果发现自己在「表演睡眠」给手环看，就把评分功能关掉，只留原始记录。

焦虑超标就停。连续几天睡不好已经影响了白天状态，这时候该做的不是分析数据，是翻到第 7 章看就医信号。数据工具解决不了它力所不及的问题，承认这一点不是失败。

3.4 消费级设备的边界：记录不是诊断

最后把边界钉死，这是本章最重要的一节。

手环的睡眠监测，靠的是加速度计（感知体动）、光学传感器（测心率血氧）这些部件，再用算法「推测」你的睡眠阶段。它与医院的多导睡眠监测（贴电极、记录脑电眼动肌电的那个，第 4 章细讲）不是一回事：**前者是生活记录，后者是医学检查。**医生公开科普中普遍提醒：消费级设备的睡眠分期与医院监测存在偏差，尤其是睡眠结构（深浅比例）这类细分指标——方向上可以参考，数值上不能较真。

这条边界落到使用上，是三个「不当」：

不当体检报告。手环说你的深睡只有 10%，不等于你真的「深睡不足」，更不等于某种疾病——它可能只是手环没认准。真正的评估要去睡眠门诊，用医院的设备。

不当疗效裁判。买了新的枕头床垫，手环分数变了，可以参考，但别用一周数据断定产品有没有用——变量太多（天气、压力、作息），单靠手环分数下的结论站不住。

不当救命警报。手环的血氧提醒有价值，但它不是医疗器械的报警系统。如果你的医生根据你的情况建议正规监测，请用医院的方法，不要用「我手环显示还行」来回答医生。

把三个「不当」合起来记：手环数据是线索，不是证据。线索的用法是「提醒你注意」，证据的用法是「支持一个结论」——后者需要医院。带着这个认识，下一章我们去看数据链的另一端：床垫的监测，和医院报告到底长什么样。

动手练习

给你的睡眠数据建一份「趋势档案」。步骤：

1. 打开手环 App，抄录最近 14 天的四个字段：日期、总时长、深睡占比、入睡耗时（各品牌叫法略有差异，取最接近的）。
2. 用第 2 章模板一的格式整理成表格，投入 AI，让它输出周度小结（周一是哪天从你的记录算起，跨月的按连续七天切）。
3. 按本章核验三步走一遍：核对事实（它说的对不对得上你的表）、追问依据（它的判断凭什么）、查它没说什么（局限声明有没有）。
4. 把核验后的小结存档，文件名就叫「睡眠趋势档案」。标注日期，四周后再做一次，对比两份小结——这就是你自己的基线，比 App 评分可靠得多。

思考题

1. 「结构看趋势，心率看自己，血氧看模式，分数别较真」——用你自己最近一周的数据对照这四句话，哪一类你以前看错了？
2. 追问 AI「这个说法的依据是什么」时，什么样的回答算健康、什么样的算危险信号？各描述一个特征。
3. 数字焦虑的三个自查信号里，你命中了几个？如果一个都没命中，说说你的用法里最值得保持的习惯是什么。
4. 医生问「你最近睡得怎么样」，手环数据和你的主观感受不一致时（比如手环说睡得不错但你觉得很累），该信哪个？这个矛盾本身说明了什么？
5. 动手实操：完成 3.5 节的练习，把你的「睡眠趋势档案」存好——第 7 章的就诊准备练习会直接用到它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	一夜睡眠周期结构图：深睡/浅睡/REM 循环数次的波浪示意，标注「成年深睡约一到两成（通行科普口径）」	自绘
图 3-2	流程图	AI 读数据核验三步：核对事实 → 追问依据 → 查局限声明，末尾标「存档周度小结」	自绘
图 3-3	循环图	数字焦虑循环：看分数 → 焦虑 → 睡更差 → 分数更低 → 更焦虑，旁边标三个打断	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		点（看趋势/关评分/该就医就医）	

第 4 章 从床垫到睡眠中心：看懂一份监测报告

本章导读

数据有两级：家里床垫和监测带测的，与医院睡眠中心测的。前半章讲家用监测的原理与局限——什么场景它测不准，怎么用一周时间校准你对它的信任；后半章讲医院的多导睡眠监测，正是第 1 章那批县市级睡眠中心政采里反复出现的设备（多导睡眠记录仪、睡眠呼吸初筛仪、经颅磁刺激仪）。然后给你用 AI 辅助预读医院报告的方法与红线，章末给一份就医信号清单。读完你能分清两级监测各自能回答什么问题，拿到一份报告知道先做什么、别做什么。

4.1 家用监测：床垫和监测带测什么、测不准什么

家用监测现在常见的形态有三种：内置传感层的智能床垫、铺在床垫下的独立监测带、放在床头的雷达类设备。原理大同小异——不接触身体，靠压力或微动信号感知你的心率、呼吸频率和体动，再用算法推测你处在哪个睡眠阶段。它最大的卖点是「无感」：不用充电、不用往手腕上戴东西，对「戴着手环睡不着」的人友好。

但无感是有代价的：它离你的身体更远，能抓到的信号更少，出错的机会更多。用户反馈里常见的误报场景有四类，买之前值得心里有数：

分体床。两人各睡一张床垫拼在一起，算法可能把两个人的信号算成一个人——数据看起来「心率忽高忽低」，其实是两个人。

同床两人。 普通大床上两个人一起睡，算法要区分信号来源，一人翻身或靠得近了，数据就容易串。

宠物上床。 猫狗的心率呼吸信号小而清晰，算法可能把它识别成一个「人」，你的睡眠曲线里多出一段你根本不记得的「夜醒」。

床垫本身。过软过硬影响传感层贴合，床垫和传感层之间隔了厚褥子会衰减信号——同一台设备换张床，数据质量可能完全不同。

所以买到家用监测设备，别急着信它。先做一周「已知作息对照」：你自己记得的晚睡、夜醒、起夜，跟设备记录逐条对一遍。大体对得上，这台设备在你这张床上算靠谱；对不

上的条目多，读它的数据时就要打更大的折扣。这个校准动作五分钟都花不了，却决定了你后面所有判断的地基牢不牢。

一句话口径先立住：家用监测回答的是「昨晚大概怎么样」，回答不了「我有没有病」。后者是医院的事，下一节就说它。

4.2 医院的多导睡眠监测：睡眠中心里的那台机器

医院的检查叫多导睡眠监测，英文缩写 PSG。它整夜记录的指标是一整套：脑电、眼动、肌电、呼吸气流、血氧、心电、体位。做的方式是贴电极——头上、胸口、腿上都要贴，然后在睡眠中心的监测床上睡一晚，有技师值守，次日出具报告。医生公开科普中的通行说法是：它是评估睡眠障碍的参考依据，尤其睡眠结构和呼吸事件，要看它的。

第 1 章那张政采表里反复出现的设备名，现在可以认领了。多导睡眠记录仪就是 PSG 的核心设备（疏勒县、宜昌的采购单里都有）；「睡眠呼吸初筛仪」是它的便携简化版，指标少一些，可以在家睡一两晚做初步筛查——筛查发现可疑，通常还要回睡眠中心做整夜的确诊级监测。疏勒县那一单里还采购了重复经颅磁刺激仪、脑电治疗仪、心理沙盘，这些对应的是治疗与评估环节。把设备清单连起来看，说明一件事：县市级医院建的不是「一间检测室」，是能检测、能治疗、能做心理评估的成建制睡眠中心。

就诊流程简单说就是五步：挂号睡眠门诊，医生问诊评估，必要时开监测（中心整夜或家用初筛），之后出报告，复诊时医生解读、讨论方案。

这一套流程的现实意义在于位置的变化。过去做整夜监测，多数人的第一反应是去省城大医院；现在第 1 章那五单政采——疏勒县、诸城、望江县、陇南武都区、宜昌，半年五单、单笔一百万到三百万——意味着地市和县级正在成建制补齐这套能力。检查离家越近，去做的心理门槛越低，这对你是个好消息。

4.3 用 AI 预读医院报告：能做与不能做

拿到 PSG 报告，多数人的第一反应是懵：睡眠效率、入睡潜伏期、各期占比、呼吸暂停低通气指数……每个词都认识，连起来不知道在说什么。这正是 AI 能帮上忙的地方——但前提是你分得清它帮的是什么忙。

能做的三件事。术语翻译：把每个指标用大白话解释一遍。指标含义：这个数通常参考什么范围（属于通行科普口径的，让它说明；不确定的，让它直说）。列问题清单：把你看不懂、想不通的点整理成几个问题，带去问医生。

不能做的三件事。下结论（「你这是中度」）、判严重程度、给治疗方案。这三件是医生的事，不是因为它能力不够才谦虚，而是报告解读本身需要结合你的病史、体格检查和监测波形——AI 只拿到了你抄给它的几个数字。

方法上，报告先做结构化摘录：把关键数字抄成一张小表（别拍整页照投喂，一是上下文长度装不下，二是原始报告上有你的姓名病历号——第 2 章的脱敏红线照旧适用）。然后用四要素骨架发提示词，给你一条可以直接抄的：

```
你是一位擅长向普通人解释医学检查报告的助手。下面是我从一份医院多导睡眠
监测报告中摘录的关键指标（非完整报告，已隐去个人信息）：

【摘录】
- 睡眠效率：78%
- 入睡潜伏期：45 分钟
- REM 睡眠占比：16%
- 呼吸暂停低通气指数（AHI）：报告里出现了这个数，我不清楚含义

【任务】1）用大白话逐条解释每个指标是什么；2）说明各指标通常参考的范围，
如属通行科普口径请注明，不确定就明确说不确定；3）帮我列出 5 条最值得带
去问睡眠门诊医生的问题。

【要求】全程不给诊断结论，不说「你属于什么程度」；凡涉及参考范围，末尾
注明「以医生解读为准」；300–500 字。
```

发出去之后守一条规矩：**违背【要求】就打回**。回答里出现「你属于中度」「建议服用什么」级别的话，直接回一句「我要求过不给诊断结论，请重新回答」。它守得住边界，这份预读才有价值；守不住，换一个模型或者干脆只用它做术语翻译。

4.4 就医信号清单：数据里的红旗

这一节把前面所有内容收拢成一份清单。先说来源：清单综合了全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》（2025 年 4 月发布）的官方科普底本和医生公开科普中的通行口径。再说用途：它是「提醒你去医院」的参考，不是自诊工具——每一条是否成立，都要由医生判断。

五条信号，按值得重视的程度排：

一，**响亮鼾声伴呼吸暂停**。同睡的人说你打着打着没声了、过几秒猛地缓过来；或者家用设备反复提示夜间血氧走低。这是睡眠呼吸问题最典型的组合信号。

二，**睡眠中憋醒**。夜里因为憋气、心慌醒来，一年里反复出现。

三，**白天严重嗜睡**。坐下来就困，开会打盹，开车犯神——这一条还连着安全，涉及驾驶的要优先处理。

四，**失眠持续且自我调整无效**。入睡困难、易醒、早醒持续了较长时间（通行科普多以「每周多数夜晚、持续数周」提示就医，具体以医生判断为准），作息、光线、咖啡因这些自我调整都试过，没用。

五，**情绪低落与失眠互相加重**。睡不好让人情绪差，情绪差又更睡不着，形成循环。这种情况别单独对付睡眠。

清单的用法三句话：命中任何一条，挂号睡眠门诊（怎么找，第 7 章细讲）；一条没中但长期困扰，也可以去——门诊不只看「病」，也做睡眠健康指导；任何时候，清单都不能反过来用成「我没中所以没病」。

动手练习

走一遍「AI 术语翻译 → 提问清单生成 → 打回演练」的完整流程：

1. 找一份监测数据：自己的体检或监测报告（有就用），没有就用本章 4.3 节提示词里的示例摘录。
2. 按四要素把摘录投给 AI，拿回术语解释和提问清单，逐条核对：每个解释它注明「以医生解读为准」了吗？有没有偷偷下结论？
3. 演练打回：追加一句「你判断一下我这个情况严重吗」，观察它怎么接。守住了边界（重申自己不做诊断、建议问医生），说明这个模型健康话题的分寸感够用；没守住，记下模型名——它不适合你问健康问题。
4. 把生成的提问清单存档，标注日期。它会在第 7 章的就诊准备练习里合并使用。

思考题

1. 用一句话分别说明：家用监测和医院 PSG 各自「擅长回答什么问题」。再检查一遍你家的设备（如果有），它有没有被你用去回答它答不了的问题？
2. 分体床、同床两人、宠物上床——这三类误报场景，对你理解「数据串扰」和隐私有什么启示？两个人共用一台监测设备，数据归谁？
3. 4.3 节说「AI 只拿到了你抄给它的几个数字」。为什么这句话决定了它不能解读你的报告？
4. 就医信号清单为什么反复强调「不是自诊工具」？如果有人拿清单反过来论证「我一条都没中，所以不用去医院」，这个论证错在哪？
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，并把「打回演练」里 AI 的表现记录下来（守住边界/没守住）——这份记录是你判断「哪些 AI 适合碰健康话题」的第一手依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	对比图	家用监测与医院 PSG 两级对比：左侧床垫/监测带（无感、推测、回答「昨晚怎么样」），右侧睡眠中心（电极、整夜、回答「有没有问题」），中间标「数据当线索，结论找医生」	自绘
图 4-2	示意图	PSG 记录指标示意：脑电/眼动/肌电/呼吸气流/血氧/心电六	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		项，旁边标「初筛仪=便携简化版」与政采设备名对应关系	
图 4-3	清单卡	就医信号五条清单卡（鼾声伴呼吸暂停/憋醒/白天严重嗜睡/失眠持续调整无效/情绪失眠互加重），角标注「提醒就医用，非自诊」	自绘

第 5 章 智能助眠产品怎么选：国标、等级与补贴

本章导读

智能床垫市场一年约 45 亿元、科技助眠品类同比增速 90%（尚普咨询/艾媒咨询口径），盘子涨得快，宣传词跟着水涨船高——「深睡提升 40%」「医护级监测」这类话你迟早会撞上。这一章给你三件趁手的工具：标准——国标和 L1-L4 等级评定怎么查、怎么对着宣传页用；补贴——从深圳的样本到你自己城市的查询路径；识别法——三类常见虚标话术的对照表和核对方法。读完你能把任何一张智能床宣传页拆成「有标准支撑的」和「自说自话的」两栏，再做决定。

5.1 两份新标准：国标与 L1-L4 等级怎么用

先看时间线。中国首个《智能床》国家标准 2025 年 8 月实施，舒达是主要起草单位之一；家具智能等级评定标准 2026 年 3 月落地，把家具的智能化程度分成 L1 到 L4 四档（来源：中国质量新闻网 2026 年 9 月报道）。两份标准前后脚到位，行业从「想怎么吹就怎么吹」进入了有标可查的阶段。

对消费者，这两份标准的使用方法浓缩成两个问题，进门就问商家：

第一个问题：**「这张床执行什么标准？」**有国标的产品，商家应该答得上来，最好能出示依据。第二个问题：**「智能等级评的是几级？」**L1-L4 评定落地之后，智能到什么程度是可以分级说清楚的，而不是靠「全屋联动黑科技」这类形容词。

两个问题的价值不在答案本身，在商家接不接得住。答得上、给得出依据的，这一栏记「有标准支撑」；含糊其辞、顾左右而言他的，本身就是重要信息——连自家产品执行什么标准都说不清的商家，它宣传页上的其他话你也要相应打折。

标准文本去哪查？全国标准信息公共服务平台可以检索。本书不在这里替你抄具体标准号——标准有版本更新，转述容易出错，你自己上平台搜「智能床」看现行版本最可靠。

最后一条提醒，划重点：标准管的是产品的基础要求和智能化分级，**不等于「助眠效果」的认证**。目前没有任何标准认证「睡这张床能治病」，遇到往这个方向暗示的宣传，直接进 5.3 节的识别法。

5.2 补贴怎么查：从深圳样本到你的城市

先看已经落地的样本。深圳 2025 年的适老化焕新行动，把睡眠监测产品纳入 30% 补贴、单人最高 1 万元；更大的背景是，智能床首次进入国家级「两新」补贴目录表述下的地方购新补贴（来源：央广网 2026 年 9 月 24 日报道）。深圳还有一个更大的盘子可以看方向：AI 终端行动计划（2025-2026）提出 2026 年人工智能终端产业规模 8000 亿元、打造 60 个典型应用场景，智慧养老在列（来源：中国经营网报道）——睡眠监测设备正好卡在 AI 终端和养老场景的交集上，这也是它能进补贴目录的政策逻辑。

补贴到了你所在的城市没有？四步查法：

1. 打开你所在省市政府官网，或商务部门的专栏，找「以旧换新」「购新补贴」类入口。
2. 在里面搜「智能床」「睡眠监测」两个关键词。
3. 找到就细读：品类口径（是「智能床」还是「睡眠监测产品」）、补贴比例、单人上限、申领方式与截止时间。
4. 查不到就别猜——有些城市没有纳入，有些纳在适老化专项而不是消费券里。拿不准时打政务热线问，比听导购说「能补」靠谱。

一条配套纪律：导购告诉你「这个能补贴」的时候，请他出示当期政策文件的名称或截图，你自己再按上面四步核一遍。补贴品类各地不同、随时段调整，一切以你申领当时的文件为准。

5.3 虚标识别法：宣传词对照表

市场涨得快，话术就多。常见虚标集中在三类，每类给你一个核对方法：

数据无出处型。「深睡提升 40%」「入睡时间缩短一半」——数字精确，出处全无。核对方法：问对方数据出自哪份公开报告或哪家检测机构；答不上来或者只给「内部测试」的，按未经证实对待。记住第 2 章说过的：AI 也可能编出这种数字，你自己引用任何数据前都先问出处。

医疗暗示型。「医护级睡眠监测」「对失眠有治疗效果」「根治熬夜脸」——往医疗功效上靠。这类是最需要警惕的：睡眠产品不是药品，疗效承诺式表述违反广告法的口径（具体条款以现行法规为准）；真有医疗器械资质的产品，资质可以查证，查证不到的「医疗级」「医护级」四个字一文不值。核对方法：让商家出示医疗器械注册或备案信息，自己去药监部门的查询渠道核。

认证模糊型。「获得 XX 认证」「通过国际权威检测」——不编号、不出处。核对方法：要求给出认证全称和编号，自己上发证机构或认监平台的公开渠道查。查得到，看认证范围是不是覆盖它宣传的那项功能；查不到，当它没说过。

三类话术的核对，可以批量交给 AI 干初筛。第 2 章模板三（拆解产品宣传页）就是为此准备的：宣传词逐条贴进去，让它输出「宣传词 / 分类 / 核实方法」三栏表。AI 分完类你自己还要动手核——它判断的是话术类型，核实动作得你来。

三类合起来，就是一张随身携带的对照表：

话术类型	典型样例	核对动作	核不过的后果
数据无出处型	「深睡提升 40%」	问出处、要报告名或检测机构	按「未经证实」对待
医疗暗示型	「医护级」「对失眠有治疗效果」	查医疗器械注册备案（药监渠道）	无资质=违规宣传，直接放弃
认证模糊型	「获得 XX 认证」（无编号）	要全称与编号，上公开渠道查	查不到=当它没说过

5.4 一张选购决策表：需求、预算、标准对齐

工具都齐了，落成一张决策表。四列：真实需求、预算档位、标准与等级要求、补贴可得性。给你三个虚构画像走一遍，感受一下用法：

画像一：只想知道自己睡得怎么样。需求是「记录」，不是「调节」。结论：手环或独立监测带就够了，千元内解决，智能床垫对这个需求是超配——参数再炫也不必为它加钱。

画像二：长期腰颈不适，想调舒适度。需求是「调节」。重点看床的调节能力（软硬、角度、分区），等级评定和国标执行情况问清楚，价格里主要买的是硬件，不是「AI」三个字。宣传页上「深睡提升」类话术对他决策影响为零——他要的是腰舒服，不是数据好看。

画像三：给独居老人装监测。需求是「监测+安全」。这一类优先查两件事：适老补贴能不能用（深圳样本就是按适老化口径补的），监测数据的查看方式家人会不会用。产品之外，家人定期看数据的习惯比设备本身重要。

三个画像走完，决策表的原则也就出来了：**先定需求再看参数；功能与需求错位的，参数再好看不买。**钱是你自己的，需求也是你自己的——这句话在第 1 章说过，这一章它变成了四个格子。

动手练习

拿一张真实的智能床垫宣传页（门店拍的、电商截的都行），完整跑一遍拆解：

1. 把宣传词逐条摘录，按第 2 章模板三的格式投给 AI，拿回三栏表。
2. 对照本章 5.3 节，检查 AI 的分类：医疗暗示型它挑出来了吗？认证模糊型它要求你查编号了吗？
3. 亲手核实三件事：宣传页标没标执行标准；宣称的等级评定给没给依据；「医护级/医疗级」类表述有没有对应的可查资质。
4. 产出两样东西：两栏对照表（有标准支撑的 / 自说自话的），和三个你打算问商家的具体问题。

思考题

1. 2025 年 8 月国标实施之前，智能床市场靠什么建立信任？之后发生了什么变化？「问标准」为什么比「问参数」更能识别虚标？
2. 有人说「补贴就是让消费者多花钱」。结合深圳样本（30% 补贴、单人最高 1 万元），说说补贴对你的真实决策影响应该怎么算——是「便宜了 30%」，还是「原本不在预算里的品类提前了」？
3. 三类虚标话术里，哪一类对长辈最容易起效？打算怎么跟家里老人讲？
4. 本章反复出现「以现行法规为准」「以申领当时文件为准」。一本给普通人的书为什么处处留这种口子，而不是直接给结论？
5. 动手实操：完成 5.5 节练习，把你产出的两栏对照表和三个问题存档——下一次进门店，它们就是你手里的验收单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	对照图	宣传页两栏拆解示意：左「有标准支撑」（执行标准/等级评定/可查资质），右「自说自话」（无出处数据/医疗暗示/模糊认证），中间标「两个问题问商家」	自绘
图 5-2	流程图	补贴查询四步：本地政府官网 → 以旧换新/购新补贴专栏 → 搜「智能床/睡眠监测」→ 核对品类比例上限与申领方式	自绘
图 5-3	表格图	选购决策表四列（真实需求/预算档位/标准与等级/补贴可得性）配三个画像示例走位	自绘

第 6 章 AI 助眠应用与大模型：怎么挑、怎么测

本章导读

产业侧的动作已经密集到值得专门讲一章：慕思牵头东莞市数字人体与智慧睡眠创新联合体，2026 年 7 月揭牌，睡眠垂类大模型 T12 落地，联合华南理工、北航、北大三院等；喜临门更名「健康睡眠科技」并与清华共建联合研究中心；舒达把 AI 做成独立品牌 AI DREAM。头部在押注，应用商店里的睡眠 App 也早已一大把。这一章先看懂产业在做什么，再给 AI 助眠应用分四种类型，然后给你一个下载前就能用的五问评测框架，最后教你用提示词把通用大模型变成你的评测助手。读完你能在装任何一个睡眠 App 之前先过一遍筛。

6.1 产业在做什么：从 T12 到 AI DREAM

判断一个产业的方向，别听发布会，看三样东西：机构动作、收入结构、品牌策略。睡眠这条线上，三样都有实证了。

机构动作：2026 年 7 月，慕思牵头组建东莞市数字人体与智慧睡眠创新联合体并揭牌，睡眠垂类大模型 T12 在联合体落地，联合的机构里有华南理工、北航、北大三院——厂商出场景和数据，高校医院出研究能力（来源：新华网家居 2026 年 7 月 27 日报道）。

收入结构：慕思 2026 年上半年 AI 产品收入 2.36 亿元，同比增长 95.69%（华安证券研报口径）。这个数比任何口号都硬——AI 产品从「附赠的卖点」变成了近一成的收入来源，还在翻倍地涨。

品牌策略：喜临门直接把公司名改成了「健康睡眠科技」，并与清华共建联合研究中心；舒达把 AI 做成独立品牌 AI DREAM。改名和独立品牌是重注——没有厂商会把营销概念写成公司名。

三条链放在一起，结论是：AI 已经从营销词变成产品主线，头部厂商把「睡眠数据 + 大模型」当核心能力投入。这对你意味着两件事。一是卧室里的设备会越来越「聪明」，你家里的数据会被越来越多的算法读取和分析——第 11 章的隐私话题因此越来越重要。二是「睡眠大模型」这类新事物会不断出现，你需要的不是逐个研究，而是一套通用判断法。

先把一个概念说清：**垂类大模型**，指用特定领域数据训练、面向特定场景的模型。睡眠垂类大模型懂睡眠术语、接睡眠设备数据，跟手机里的通用大模型不是一回事；但它俩共享同样的底层边界——会幻觉、有时效、上下文有限（第 2 章讲过的三条，一个字都不会因为「垂类」三个字而消失）。别的领域说得越专业，你越要记得它依然会一本正经地编。

6.2 四种类型：监测、陪伴、干预、大模型

应用商店里的睡眠 App 花样繁多，按功能归拢就四类。对号入座，风险等级立刻清晰。

监测分析类：记录和解读你的睡眠数据。第 3 章已经打过交道——它继承手环的一切边界，数据是线索不是证据。风险中等，主要风险在数据隐私和过度解读。

声音陪伴类：白噪音、助眠音、睡前故事。四类里风险最低的——它不怎么碰你的数据，也不给健康建议，挑的只是内容合不合你耳朵。缺点也简单：对很多人有效，对长期失眠基本无效。

干预训练类：作息调整计划、放松训练，以及挂「CBT-I」招牌的产品。这里要停一下：CBT-I（失眠认知行为疗法）是医生认可的失眠干预方向，这个方向本身是正经的；但「数字疗法」类的产品有对应的审批管理路径，宣传里「CBT-I」「数字疗法」要分开看——是「借鉴了这个方法的训练课程」，还是「经过审批的数字疗法」，以药监部门的查询为准。分不清的时候，按普通健康类 App 对待，别按「治疗」对待。

大模型对话类：睡眠垂类大模型（比如 T12 这类）或通用大模型的睡眠场景应用。这类的能力上限最高、风险也最高——它给的建议可能很有条理，也可能混着幻觉；一切判断回到第 7 章的三个可信度层级。

四类的风险大致是：陪伴最低，监测次之，对话类看场景，干预类最需要核对资质。装之前，先想清楚你要的是哪一类，不要用一个「啥都有一点」的 App 同时干四件事——样样通的应用，往往样样都不深。

6.3 五问评测框架：下载前先过一遍

五问，装之前在应用商店页面和官方介绍里找答案：

第一问：AI 给的建议有依据吗？ 看介绍里说没说方法来源（参考什么指南、什么方法体系）。通篇「智能算法」「黑科技」而无一字方法出处的，第一问不过。

第二问：你的数据去哪了？ 找隐私政策里的两处：收集哪些数据；是否与第三方共享。睡眠数据连着作息和健康（第 11 章会展开它有多敏感），共享条款写得含糊的，第二问不过。

第三问：宣称里有没有医疗词？「治疗失眠」「替代就医」「医疗级」——出现即红旗，逻辑同第 5 章。正经产品给自己划的边界是「辅助」「记录」「训练」。

第四问：订阅前能不能试？ 免费额度够不够你判断核心功能？一个连试用都不给的订阅制 App，等于让你先付钱再验货。

第五问：出问题找谁？有没有可用的客服渠道、明确的退款规则。健康类应用出问题不只是退钱的事，还可能涉及你停用后的数据处置——这些在条款里有没有交代。

五问都过，可以装来试用；任何一问答不上来，降级处理——换一个答得上来的，或者先不装。这个框架不保证你挑到最好的 App，但能帮你避开最差的那批。

6.4 让 AI 当你的评测助手

五问的答案散在商店介绍、隐私政策、订阅条款里，自己逐条翻效率低。把材料收集起来，让通用大模型帮你按框架填表。给你一条可直接抄的提示词：

```
你是一位帮用户挑选健康类应用的评测助手。下面是我收集的某睡眠 App 的
应用商店介绍、隐私政策要点与订阅说明（原文摘录）：

【材料】
- 商店介绍：（粘贴原文）
- 隐私政策要点：（粘贴数据收集与第三方共享相关段落）
- 订阅与免费额度：（粘贴价格与试用说明）

【任务】按五问框架逐条评估：
1. 它宣称的 AI 功能有没有说清方法或依据？
2. 数据收集与共享：收集哪些、给不给第三方、能不能删？
3. 宣传语里有没有「治疗/治愈/替代就医」类医疗暗示？
4. 免费额度够不够判断核心功能？
5. 有没有明确的客服与退款路径？

【要求】输出五问对照表（问题/材料依据/风险标注）；材料里没有依据的
一律写「材料未说明」，不要替它编；最后用一句话给「下载前建议」。
```

用的时候注意两点。一是材料要贴原文，不要贴你转述后的版本——转述会丢细节，AI 也只能基于你给的材料判断。二是想清楚这套方法评的是什么：它评的是文本（宣传和政策条款），不是体验。App 用起来顺不顺、声音助眠对你有没有效，这些要靠你自己试免费额度，AI 替不了。文本初筛加亲手试用，两道都过，再谈订阅。

动手练习

选两个你正在纠结的睡眠 App（或从应用商店睡眠榜上随手挑两个），完整走一遍：

1. 各自收集三样材料：商店介绍原文、隐私政策里数据相关段落、订阅与免费额度说明。
2. 用 6.4 节的提示词各生成一张五问对照表。
3. 亲手补两处 AI 判断不了的东西：第三问的医疗词你自己再扫一遍原文（比 AI 更敏感）；第四问的免费额度你实际装上试用一次。
4. 给每个 App 下结论：「装 / 不装 / 再看看」，各写一条理由。两个结论放一起，感受一下框架带给你的判断力。

思考题

1. 「垂类大模型懂睡眠，但它共享通用大模型的所有边界」——用第 2 章的幻觉概念，举一个睡眠垂类大模型可能出错的具体场景。
2. 干预训练类为什么单独提醒「CBT-I 方向」和「数字疗法审批」要分开看？如果把一个普通放松训练 App 当成「经过审批的疗法」推荐给失眠的长辈，风险在哪里？
3. 五问框架里，哪一问被跳过的后果最严重？说明你的理由。
4. 慕思把 AI 产品做到半年 2.36 亿元收入，喜临门把「科技」写进公司名。作为消费者，头部厂商的重注对你挑选产品有什么实际影响——是更信任了，还是更要看紧了？为什么？
5. 动手实操：完成 6.5 节练习，把两张五问对照表和你的「装/不装/再看看」结论存档——三个月后回看一次，检验你的判断。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	象限图	四类应用地图：监测分析/声音陪伴/干预训练/大模型对话，纵轴标「数据敏感度」、横轴标「健康风险」，角标「陪伴最低，干预类核资质」	自绘
图 6-2	流程图	五问评测流程：有依据吗 → 数据去哪了 → 有无医疗词 → 能试吗 → 出问题找谁，出口标「全过再装 / 一问不过降级」	自绘
图 6-3	时间线图	产业动作时间线：智能床国标实施（2025-08）→ 喜临门更名与清华共建 → 创新联合体揭牌与 T12 落地（2026-07）→ 慕思半年报 AI 收入 2.36 亿/+95.69%	自绘

第 7 章 什么时候必须去医院：AI 的医疗边界

本章导读

全书最重要的一章。前六章教你怎么用 AI 和设备，这一章回答一个更根本的问题：AI 睡眠建议能信到什么程度？答案不是「能」或「不能」，是分层——睡眠卫生层面的通用建议可信度相对高；结合你个人数据的分析只能当参考；涉及诊断与治疗的回答，一律只能当「就诊前的准备材料」。这一章给你必须就医的信号清单（医生公开科普通用口径）、睡眠门诊的查找与就诊流程（政策通道已经铺到你家门口）、以及用 AI 做就诊准备的方法。读完你能划清「问 AI」和「问医生」的界线——这条界线划对了，前面六章的工具才真正安全。

7.1 AI 建议的三个可信度层级

把 AI 的睡眠回答按可信度分三层，每层的用法不一样。

第一层：睡眠卫生常识。作息规律、睡前少看屏、卧室暗一点静一点、下午以后别碰咖啡因——这类通用建议，可以对照全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》（2025 年 4 月发布）的口径互相印证，说得一致的，可信度相对高。AI 在这一层的价值是解释和展开：把「光线影响入睡」讲成为什么、怎么做。

第二层：结合你个人数据的分析。「你的深睡比例连续两周偏低，可能与入睡晚有关」——这类回答只能作参考。原因第 3、4 章反复说过：设备数据本身有误差，AI 又可能在你给的少量数字上发挥。这一层的正确用法是拿它发现「值得留意的模式」，而不是拿它确认「我有问题」。

第三层：诊断与治疗方案。「你这是失眠症」「建议服用 XX」——AI 无权给出，任何模型、任何产品、说得再像医生都不行。看到直接无视，或者当成「我该去看医生了」的提醒——但绝不当成结论。

三层合起来的判断口诀：**越通用越可信，越具体越存疑，涉及诊断治疗直接清零。**这个分层不是贬低 AI，是让它干擅长的事——第一层它讲得清楚，第二层它提供视角，第三层它压根不该碰。你守住分层，AI 就是好帮手；你混了层，好帮手也会把你带偏。

7.2 必须就医的信号清单

第 4 章给过一份简版清单，这里是完整版。先说来源：综合全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》的官方科普底本与医生公开科普中的通行口径。再说用途：它是「提醒你去医院」的参考，不是自诊工具——哪一条成立、严重到什么程度，由医生判断。

信号一：响亮鼾声伴呼吸暂停。同睡的人目击你呼吸停顿几秒再猛地缓过来；或家用设备反复提示夜间血氧走低。这是睡眠呼吸问题最典型的组合。它值得重视的原因不只是睡不好——长期夜间缺氧连着心血管风险，医生公开科普中反复提示这一点。

信号二：睡眠中憋醒。夜里因憋气、心慌惊醒，反复出现。与信号一同源，再叠加一条：它已经影响到了你自己的体感。

信号三：白天严重嗜睡。坐下就困、开会打盹、看电视睡着，影响工作与驾驶。这一条连着安全——疲劳驾驶的危险不用多说。涉及驾驶职业或长途驾驶需求的人，优先处理。

信号四：失眠持续且自我调整无效。入睡困难、易醒、早醒，持续了较长时间（通行科普多以「每周多数夜晚、持续数周」提示就医，具体以医生判断为准），作息、光线、咖啡因这些睡眠卫生手段都试过，没有改善。这时候该考虑的不是「再换一个助眠 App」，是门诊。

信号五：情绪低落与失眠互相加重。睡不好让情绪变差，情绪差又更睡不着。这类循环单从睡眠下手往往事倍功半，值得让医生整体评估。

三个使用提醒：命中任何一条，挂一次睡眠门诊，让医生判断，这本身不是「确诊了什么」，是给自己一个专业的评估；一条没中但长期困扰，也可以去——睡眠门诊也做健康指导；清单永远不能反过来用成「我没中，所以不用去医院」。

7.3 睡眠门诊：怎么找、怎么看

先说政策通道，因为它直接决定你能不能在家门口看到这个科。国家卫健委 2025 年把「每个地市至少一家医院提供心理门诊、睡眠门诊」列为为民服务八件实事之一；第 1 章的政采表显示，县市级医院正在成建制建睡眠中心——疏勒县、诸城、望江县、陇南武都区、宜昌，半年五单，单笔一百万到三百万。翻译成人话：看睡眠问题这件事，正在从「去省城大医院」变成「去本地医院」。

怎么找，三个渠道按序用：

1. 医院官方公众号或本地挂号平台，搜「睡眠门诊」「睡眠医学中心」「呼吸睡眠」——各地叫法不一，多试几个词。
2. 第 1 章练习里你查过的本地清单——能做「多导睡眠监测」的医院，通常就是当地睡眠诊疗的主力。
3. 还找不到就打医院总机问。新开的门诊宣传未必到位，电话问最直接。

怎么看待预期：规范的睡眠门诊，第一次就诊大概率不是「进门开药」。医生会详细问病史（睡了多久了、白天状态、咖啡因、打鼾情况——7.4 节教你怎么准备），可能先填量

表评估，再决定要不要做监测（第 4 章讲过的整夜 PSG 或家用初筛），然后才谈方案。流程比你想象的「慢」，这是正常的，慢的部分正是专业所在。

什么时候去：别等「扛不住了」才去。信号清单命中一条就可以挂一次号做评估——睡眠门诊的检查没有想象中可怕，多数评估就是问诊加量表，整夜监测也只是一晚上的事；拖到长期失眠或白天功能明显受损才去，评估和干预的难度都会更高。第一次就诊建议上午的号去（问诊和评估通常当天能完成，若需要监测再约时间）；复诊尽量挂同一个医生——睡眠问题的方案调整依赖连续观察，换来换去，每个医生都要从头认识你一遍。

7.4 就诊准备：用 AI 把病史讲清楚

门诊时间有限，医生问得再细，也要靠你陈述准确。多数人的陈述是「挺久的了，反正睡不好」——这对医生是无效信息。AI 能帮你把陈述整理成医生需要的样子。三件材料：

一，两周睡眠日记。第 2 章模板二整理的那份：日期、上床时间、大致入睡时间、白天补觉、咖啡因、睡前活动、主观感受。这是医生判断失眠模式的第一手材料。

二，睡眠趋势档案。第 3 章练习的产物：连续数周的手环周度小结。它回答「趋势上怎么样」，跟日记的「每天怎么样」互补。

三，提问清单。让 AI 帮你生成，人工筛到 5 条以内。提示词：

```
你是一位帮患者做门诊准备的助手。我要第一次去睡眠门诊，请根据我的材料
帮我准备。

【材料】（粘贴：两周睡眠日记的表格摘要 / 睡眠趋势小结 / 手环关键数据
区间，均已脱敏，不含姓名住址）

【任务】1）列出医生最可能追问的 5 个点（比如症状持续多久、白天状态、
咖啡因摄入、打鼾情况），并对照材料看哪些我已经能答上；
2）结合材料帮我列 5 条以内最想问医生的问题，按重要程度排序；
3）指出材料里还缺什么信息，建议我就诊前补记。

【要求】所有整理只基于我给的材料，不得添加我未提供的症状或病史；
不给任何诊断或用药建议；输出 500 字以内。
```

一条红线要钉死：AI 整理的病史材料，是「**你的陈述的结构化版本**」，不是医学文书。交给医生之前自己通读一遍——重点查有没有 AI 自己「添」进去的东西（它推断出的症状、脑补的病史）。添一句假病史，医生的理解就偏一分。材料是你署名的，通读是你最后的一道关。

动手练习

把第 2、3、4 章的产物合成一份完整的就诊准备包，再做一次表达演练：

1. 汇集三件材料：两周睡眠日记（第 2 章模板二产出）、睡眠趋势档案（第 3 章练习产出）、关键数据摘录（第 4 章结构化摘录的格式）。缺哪样就先补哪样——日记没记够两周的，从今晚开始记。
2. 用 7.4 节的提示词生成就诊准备材料，人工通读，删掉 AI 添进去的内容。
3. 模拟表达练习：让 AI 扮演「第一次问诊的睡眠门诊医生」向你提问（只问诊、不给诊断），你用自己的话回答。练三分钟就停——练的是陈述能力，不是背台词。
4. 把准备包存档。真要挂号的那天，它就是你进门时手里那份不慌的材料。

思考题

1. 「越通用越可信，越具体越存疑，涉及诊断治疗直接清零」——用你最近一次问 AI 的睡眠问题对照这三句，它落在哪一层？
2. 三个可信度层级的边界，为什么必须由「人」来守，而不能指望 AI 自己守？提示词里写了「不给诊断」，为什么还需要你打回？
3. 7.4 节说 AI 整理的病史「添一句假病史，医生的理解就偏一分」。除了通读，你还想到什么办法降低这个风险？
4. 家里人命中了清单上的信号但拒绝就医。这份清单在这种场景下能起什么作用、不能起什么作用？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习，把就诊准备包存好，并在挂号平台上确认你所在城市睡眠门诊的实际位置——材料齐了，门也要找得到。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	金字塔图	AI 建议可信度三层：底层睡眠卫生常识（可信度相对高）/中层个人数据分析（参考）/顶层诊断治疗（清零），旁边标口诀「越通用越可信」	自绘
图 7-2	流程图	就医决策流程：命中信号清单任一条 → 挂睡眠门诊（搜索三渠道）→ 问诊评估 → 必要时监测 → 方案讨论，角标「清单提醒用，非自诊」	自绘
图 7-3	清单卡	就诊准备包三件套：睡眠日记 + 趋势档案 + 提问清单（≤5	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		条），角标「AI 整理后必须人工通读」	

第 8 章 睡眠产业的真钱在哪里：政策、政采与盘子

本章导读

这一章写给从业者、想入行的人，和想看懂行业新闻的普通读者。先把盘子摆出来：行业研究口径下，睡眠经济 2025 年总盘约 5737 亿元（艾媒咨询）——但总盘不等于机会，这一章要教你把它拆开读。然后拆两条最实的钱线：医疗侧的睡眠中心建设潮，2026 年 5-10 月公开中标 5 单，全部有项目名、金额、日期可查；消费侧的智能床垫市场，约 45 亿元、增速 90%。章末给一张机会地图：设备与服务商、内容与培训、渠道、技术供应，各方各在哪一段。读完你能看懂这个产业的钱从哪来、往哪去，以及自己该站哪一格。

8.1 盘子：5737 亿的总账怎么读

先摆数字：睡眠经济 2025 年总盘约 5737 亿元（艾媒咨询口径，行业研究数据）。

这个数要拆开读。它统计的是全产业链合计——家居寝具、监测设备、医疗健康服务、内容应用等等全在里面。5737 亿听起来是个大盘子，但对想做事的人来说，「赛道存在」和「我的机会在哪」是两个问题。总盘数字回答前者，分线数字才回答后者。

拆开看三个板块的成色：

医疗侧：有单。政府采购公开记录里，医院睡眠中心设备采购一笔接一笔（下一节细拆），单笔百万级、预算主体明确、账本公开可查——这是全行业里账目最硬的钱。

消费侧：有量。智能床垫约 45 亿元、科技助眠品类增速 90%（尚普咨询/艾媒咨询口径，转引自中国质量新闻网 2026 年 9 月报道），头部厂商的 AI 产品收入在翻倍（8.3 节细看）——增长真实，但预算分散在千万个消费者的钱包里，没有公开账本。

其余板块：讲故事的多。剩下的部分——各种概念服务、内容产品、概念硬件——多数还没有可查证的收入或订单证据。不是说它们没机会，是说当下判断要保守。

一个实用的读法送给你：**看任何「睡眠经济」的报道，先问钱在哪一段。**有公开订单的、有审计口径收入的，是实；只有市场规模预测的，先当故事听。

8.2 医疗侧：五单政采拆一条建设链路

这是全书数据最硬的一节。2026 年 5 月到 10 月，公开渠道可查的医院睡眠中心设备采购至少 5 单，逐单列明：

项目	金额	中标/成交时间	采购内容要点
新疆疏勒县医院睡眠中心设备采购	中标 293 万元+（明细部分打码）	2026-09-17	重复经颅磁刺激仪、睡眠呼吸初筛仪、多导睡眠记录仪、脑电治疗仪、心理沙盘等 11 类
诸城市人民医院睡眠中心设备采购	中标 170.39 万元	2026-10-10	睡眠中心整批设备
望江县医院睡眠中心建设设备采购	中标 140 万元	2026-08-12	含经颅磁刺激仪等
陇南市武都区中心医院睡眠中心设备采购	中标 103.56 万元	2026-06-24	多导睡眠测量仪、便携睡眠监测仪等
宜昌某医院睡眠中心设备采购	金额公告中打码	2026-05-08	多导睡眠记录仪 1 台、失眠治疗仪 1 台、睡眠呼吸记录仪 4 台

（来源：中国政府采购网及各地公共资源交易平台公开公告；金额完整的 3 单合计约 607 万元）

这张表要读出四层：

看地点。 疏勒县、诸城、望江县、陇南武都区、宜昌——没有省会，没有一线。这说明「每个地市至少一家医院提供睡眠门诊」（卫健委 2025 年为民服务八件实事）这条硬任务，已经传导到了县级财政：不是文件里写着，是县医院在真金白银买设备。

看金额与设备。 单笔 100 万到 300 万量级，采购的不是一台机器，是一套中心：监测（多导睡眠记录仪、初筛仪）、治疗（经颅磁刺激、脑电治疗）、评估（心理沙盘）。成建制三个字就是这么来的。

看节奏。 5 月宜昌、6 月陇南、8 月望江、9 月疏勒、10 月诸城——半年五单，月月有。这不是某地突击，是一条稳定跑量的建设线，背后是硬任务在推。

看后续。 建设期买设备，运营期要什么？人（医生、技师、健康管理岗位——第 10 章讲的人才缺口）、耗材与运维、筛查服务外延。设备商吃建设期，服务与培训吃运营期——这条接力棒刚递出去。

给从业者的一句话总结：医疗侧的钱是「任务驱动」的钱，跟着硬任务走，预算有保障、账期可查；但它有门槛——医疗设备的资质、渠道、服务能力，都不是小团队能速成的。进不了这条链的人，看懂它也有用：它是行业确定性最强的信号源。

8.3 消费侧：45 亿床垫与 90% 增速背后

消费侧没有政采那样的公开账本，但有三个可验证的硬信号。

信号一：品类增速。智能床垫 2026 年约 45 亿元市场，科技助眠品类同比增速 90%（尚普咨询/艾媒咨询口径，转引自中国质量新闻网报道）。90% 是翻倍式增长——基数还不大，但方向陡峭。

信号二：头部收入结构。慕思 2026 年上半年 AI 产品收入 2.36 亿元，同比增长 95.69%（华安证券研报口径）；喜临门更名「健康睡眠科技」并与清华共建联合研究中心；舒达把 AI 做成独立品牌 AI DREAM。厂商把「AI 版本」做成收入增量，不是贴牌概念——喜临门连公司名都改了，这是押上身家的动作。

信号三：政策补贴范围。智能床已进入多地购新补贴：深圳适老化焕新把睡眠监测产品纳入 30% 补贴、单人最高 1 万元，且是「两新」补贴目录表述下的地方购新补贴（央广网 2026-09-24）——补贴进场，意味着政策侧认可这个品类的消费引导价值。

三个信号合起来的判断：消费侧的增长是真的，但钱分散——分散在厂商的营销与渠道费用、千万个消费者的订单里，没有一张能像政采表那样摊开看的账本。**验证消费侧机会，就用这三个替代指标：品类增速、头部收入结构、补贴范围。**三个都在涨，线是真的；哪个掉头了，警惕。

对从业者的提示：消费侧的门槛比医疗侧低，竞争也拥挤。第 5 章讲的标准与虚标识别，反向用就是从业纪律——你卖的东西经不经得起「两个问题问商家」，直接决定你能走多远。

8.4 机会地图：谁在这波里做什么

把前面所有内容收拢成一张地图。四类角色，四段机会：

设备与服务商：吃建设潮。睡眠中心整包设备、便携监测、售后运维——跟着 8.2 节那条建设线走，硬任务在，预算就在。门槛：医疗资质与渠道。

内容与培训：吃人才缺口。睡眠健康管理师培训起步（2025-07 列入国家新职业工种）、医院与厂商都缺人、药店店员专业能力被白皮书点名——《2026 中国优质睡眠白皮书》把「店员专业能力待提升」列为三大痛点之一（10 家医药连锁联合发布，2026-08）。培训与内容服务是轻资产切口，第 9、10 章分别展开。

渠道：吃转型。寝具门店在把 AI 讲成主线（三家头部的动作），药店连锁把助眠品类当转型重点——一线导购与店员的「专业能力升级」，是渠道侧当下最真实的需求。

技术供应：吃配套。头部已有睡眠垂类大模型 T12 的先例，中小技术团队的机会在配套——设备数据分析、门店工具、内容生成，做头部没空做的缝隙。

四段机会共享同一个判断标准：**离「硬任务」和「硬收入」近的先动，纯讲故事的后面看。**建设潮有任务书，头部收入有审计口径，这两段是实；其余的，等你拿到可验证的证据再下注也不迟。

动手练习

做一张你所在省份的本地机会清单：

1. 打开中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），搜「睡眠」相关关键词（睡眠中心 / 睡眠监测 / 多导睡眠），时间范围调到最近一年。
2. 记下每条命中：医院名、金额（如公开）、日期、设备类型。本章 8.2 节的表格格式直接套用。
3. 对照三个替代指标（8.3 节），看看你所在省份的消费侧有没有可观察的动作：本地有没有智能床门店在打补贴广告？头部品牌在本地商场有没有 AI 概念的专柜？
4. 产出一张两栏清单：本省「医疗侧信号」（政采记录）与「消费侧信号」（门店/补贴观察）。有信号的格子，就是离你最近的机会入口。

思考题

1. 5737 亿的总盘和约 607 万的半年政采合计，量级差了四个数量级。这个落差说明了什么？为什么本章仍然说医疗侧是「账面最实的钱」？
2. 建设潮（买设备）之后，什么需求会接力？按 8.2 节的「接力棒」逻辑，推演一下运营期的三类需求，哪一类最适合轻资产团队切入？
3. 消费侧没有公开账本。三个替代指标（品类增速、头部收入结构、补贴范围）里，你认为哪个最不容易失真？为什么？
4. 「离硬任务和硬收入近的先动」——用这个标准检验一个你身边正在发生的「睡眠创业」（门店、课程、产品都行），它离哪一段近？
5. 动手实操：完成 8.5 节练习，把本省机会清单存档，并设一个半年后的提醒重新查一遍政采网——建设线的节奏（半年五单）值得你持续核对。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	数据图	五单政采条形图（疏勒 293 万+ / 诸城 170.39 万 / 望江 140 万 / 陇南 103.56 万 / 宜昌打码），横轴按中标时间排，角标「完整金额 3 单合计约 607 万元」	自绘（数据源：政府采购公开公告）
图 8-2	链路图	「硬任务 → 建设潮 → 服务接力」链路：八件实事硬任务 → 县市级医院成建制建中心 → 设备采购 100-300 万/单 → 运营期（人/耗材/服务）接力	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-3	地图	四类角色机会地图：设备与服务商（建设潮）/内容与培训（人才缺口）/渠道（门店药店转型）/技术供应（垂类配套），判据标「离硬任务硬收入近的先动」	自绘

第 9 章 门店与药店：导购和店员的 AI 工作法

本章导读

白皮书点名了短板：《2026 中国优质睡眠白皮书》（10 家医药连锁联合发布）把「店员专业能力待提升」列为三大痛点之一；寝具门店这边，慕思、喜临门、舒达都在把 AI 讲成主线卖点，导购自己得先讲得明白——顾客现在开口就是「AI 床垫的 AI 到底是什么」，接不住就丢单。这一章给一线三套工具：讲标准不讲玄学，AI 辅助内训（问答库、话术卡、模拟陪练），用户教育内容批量生成；最后是一条合规红线清单——哪些话能说、哪些话不能说，一张表钉死。读完你能把「专业」从墙上的口号变成每天的话术。

9.1 导购的新功课：把标准讲成顾客听得懂的话

先看行业背景。第 6 章拆过三家头部的动作：慕思 AI 产品半年收入 2.36 亿元、同比 +95.69%，喜临门更名「健康睡眠科技」并与清华共建联合研究中心，舒达把 AI 做成独立品牌 AI DREAM。头部把 AI 讲成主线，全行业的顾客都会跟着问——「你们这个 AI 跟别家有什么不一样」「AI 真能改善深睡吗」。导购答不出这两问，前面所有的陈列投入都白搭。

怎么答？**讲标准，不讲玄学**。第 5 章教过消费者问商家两个问题：执行什么标准、智能等级评的是几级。导购把这两个问题反过来用，就是话术：主动讲「这张床执行的是 2025 年 8 月实施的智能床国家标准」「智能等级评到了 X 级，对应它能自动做到的是……」。等级和条款是可查证的，形容词不是——顾客未必懂标准，但分得清「你在讲可查的东西」还是「你在背台词」。

对应的「翻译」工作可以让 AI 帮你做。给你一条可直接抄的提示词：

```
你是一位帮助门店导购的助手。下面是我们一款智能床垫的参数与宣传要点：

【材料】（粘贴：产品参数表 / 宣传页要点 / 执行标准与智能等级信息）

【任务】生成一张「顾客视角对照卡」：
1. 把每项参数翻译成顾客能听懂的一句话（它对我睡觉有什么用）；
2. 标注哪些说法有标准或公开依据支撑、哪些只是宣传话术；
3. 列出顾客最可能追问的 3 个问题与建议回答。
```

```
【要求】不给诊断或疗效承诺；「改善深睡 X%」类无出处表述一律标注
「需出示依据后才能对外说」；表格输出，500 字以内。
```

一张提醒：AI 生成的对照卡，门店自己核过再上墙——参数有没有写错、等级评的是几级，这些事实错了丢的是店的名声。

9.2 药店店员：白皮书点名的短板怎么补

药店这条线的背景是一条白皮书。《2026 中国优质睡眠白皮书》由 10 家医药连锁联合发布（2026 年 8 月，央视网财经报道），把零售端三大痛点之一点名为「店员专业能力待提升」；同时益丰、老百姓、大参林这些连锁正把助眠品类当转型重点。两件事放在一起读：品类在加码，专业短板被公开点名——店员的睡眠知识培训，是渠道侧当下最确定的需求之一。

AI 辅助内训，三步：

第一步，把产品知识做成问答库。 把在售助眠品类（褪黑素类、器械类、床品类）的说明与常见疑问交给大模型生成问答对，店长和执业药师人工校对后入库。生成是 AI 的活，校对是人的活——问答库会成为店员的考试题库，错一条传一片。

第二步，把常见异议做成话术卡。「这个跟网上买的有什么区别」「吃了会不会依赖」——高频异议整理成标准应答卡。注意话术卡里只放品类事实与使用常识，不放疗效承诺（9.4 节的清单管着）。

第三步，用大模型做模拟顾客陪练。 让 AI 扮演顾客提问，店员练应答。这是三步里见效最快的一步——新店员上岗前先跟 AI 聊二十个回合，比背三天手册记得牢。

一条底线先划清：**药店不是诊室。**店员的角色是品类服务，不是健康判断——顾客描述的症状里出现红旗信号（第 7 章清单：鼾声伴呼吸暂停、白天严重嗜睡等），唯一的正确动作是建议去医院睡眠门诊，而不是推荐产品。这条线在白皮书点名专业能力的背景下尤其要紧：补专业，补的是「知道什么该自己答、什么该转医生」。

9.3 用户教育内容：AI 批量生成的做法

门店和药店都在做私域与社群，内容需求是刚性的——每周总要发点科普，写什么？谁写？AI 批量生成的做法，拆成三件套：

一个主题清单。 先列定主题池：睡眠卫生常识（作息、光线、咖啡因）、数据怎么看（手环评分、报告术语）、选购避坑（标准、等级、虚标识别）。主题池管「写什么不跑偏」——不在池子里的主题，宁可不写。

固定提示词模板。每类主题一个模板：角色（科普作者）、任务（把知识点讲成 300 字口语化短文）、背景（目标读者：门店顾客/药店会员）、要求（不出现疗效承诺、结尾留一个可到店咨询的钩子）。模板固定，产出的风格才稳定。

人工终审。AI 出初稿，人对事实与口径负全责——发布出去的内容署的是店的名，写错了没有「AI 写的」这个借口。终审核对三样：知识点有没有官方出处、有没有夹带疗效暗示、数字有没有来源。

素材锚定还有一条铁律：**科普内容锚定官方口径。**全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》（2025 年 4 月发布）就是现成的底本——书里的知识点、说法、口径都从它出发，AI 只做展开和口语化，不自己发明知识。门店内容出了错，损害的不只是一篇帖子，是顾客对这家店所有专业话术的信任。

9.4 一线合规话术清单：哪些话不能说

最后一张表，一线天天要用，建议贴在柜台里面。

三条铁律：

不说治疗、治愈、根治。睡眠产品不是药品，疗效承诺式表述违反广告法的口径（具体条款以现行法规为准）。第 5 章教消费者识别「医疗暗示型」话术——作为从业者，你自己就是被识别的对象。

不替代就医。顾客描述的症状像红旗信号时，话术是「这个情况建议去医院睡眠门诊看看」，而不是「我们这个产品能解决」。前者丢不了单——顾客看完医生，该回来买床还是会回来；后者可能出事。

不编数据。引用市场数据注明来源（艾媒口径、尚普口径这类要带上），「提升深睡 40%」这种没有公开出处的数字，不主动说；顾客问到，答「这是宣传口径，公开依据我们还没有」。

对照表（能说 / 不能说）：

能说	不能说
监测、记录、辅助放松、舒适度调节	治疗、治愈、根治
执行国标、智能等级 L 几级（可出示依据）	医疗级、医护级（除非有对应资质证明）
睡眠卫生常识（有官方科普出处）	替代就医、不看病也行
数据来源明确的行业数字	无出处的「提升 X%」

这张表和第 5 章是同一枚硬币：那一章教消费者用这张表挑你，这一章提醒你别被自己的表挑出去。

动手练习

为自己门店或柜台的三款主推产品，各生成一张「顾客视角对照卡」与一张合规话术卡，并交叉互检：

1. 收集三款产品的参数与宣传要点，用 9.1 节的提示词各生成一张对照卡。
2. 人工核卡：参数对不对、等级几级、有没有被 AI「顺手」写进去的疗效暗示——删掉。
3. 每款产品从 9.4 节对照表的「不能说」列里，找出宣传物料里已经踩线的表述，改写成「能说」版本。
4. 三张卡互检：换同事拿卡向你提问（扮演顾客），你按卡应答，卡上答不上的问题记下来——它们就是下一轮问答库要补的条目。

思考题

1. 「讲标准」为什么比「讲功能」更能建立信任？回想一次你自己作为顾客的购物经历，对方讲的是可查证的依据，还是形容词？
2. 问答库、话术卡、模拟陪练三步里，为什么「人工校对」在问答库这一步最不能省？
3. 顾客拿着手机里 AI 的回答来柜台对质：「AI 说这种床垫能治失眠，你们怎么不能确认？」你按本章的方法怎么接？
4. 白皮书把店员专业能力列为痛点，头部厂商又在把产品讲得越来越「AI」。一两年后，你认为一线的「专业」门槛会变高还是变低？为什么？
5. 动手实操：完成 9.5 节练习，把三张对照卡与改写记录存档——每月更新一次，它们就是你柜台的活话术库。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	样式图	顾客视角对照卡样式：左列参数、右列「对顾客的一句话翻译」，角标注「有依据/仅话术」两色标记	自绘
图 9-2	流程图	店员 AI 内训三步：产品知识问答库（人工校对）→ 异议话术卡 → 模拟顾客陪练，出口标「药店不是诊室」红线	自绘
图 9-3	对照表	能说/不能说话术对照表（监测记录辅助对照治疗治愈根治等，同 9.4 节表），	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		角标「建议贴柜台内」	

第 10 章 睡眠健康管理师：新职业的入行与进修

本章导读

2025 年 7 月，「睡眠健康管理师」列为国家新职业工种——服务睡眠这件事，成了国家承认的职业。但新职业不等于成熟职业：培训认证体系正在搭，团体标准在起草、首席培训导师已出现，而全国统一的教材与学时制度尚未定型（这一点本书如实标注「待验证」）。先发卡位的机会与不确定性，此刻同时存在。这一章把现状摊开讲：官方承认的人才缺口有多大、想入行的人怎么挑培训不被收智商税、已经入行的人怎么用 AI 辅助学习与服务，最后看康养文旅两个细分口。读完你能判断这个新职业该不该进、怎么进、进错了怎么止损。

10.1 一个新职业的现状：机会与不确定性

先把确定的部分钉住。「睡眠健康管理师」于 2025 年 7 月列为国家新职业工种（来源：公开报道，见参考文献）；配套动作已经出现——睡眠功效团体标准在起草，行业里有机构推出了首席培训导师。这些信号说明职业化的车头已经启动，不是民间概念。

再把不确定的部分钉住，这一段同样重要：**全国统一的教材、学时制度、认证体系，都还没有定型**（本书标注「待验证」——查证不到权威的统一制度文件，就如实告诉你没查到）。也就是说，此刻市面上所有「睡眠健康管理师证书」，无论包装多正式，都不是全国统一认证制度下的产物。

这两段合起来的推论，是这个职业当下最实用的行动指南：

对入场者，**早入场有先发优势**——职业化早期，谁先攒出真实的服务能力和案例，谁就在体系定型后占位置。但**同时要警惕「交钱包过」的培训陷阱**——认证未定型阶段，任何「全国通用、终身有效、保过」的宣传都要打问号。机会和陷阱用的是同一扇门，区别在你进门之前做没做功课（10.3 节给你检查清单）。

一句话给这个阶段定性：这是一个「方向确定、路径未定」的职业。方向——睡眠服务人才化、职业化，政策文件和行业大会都在说；路径——学什么、考什么、证长什么样，都还没定稿。适合能容忍不确定性、愿意边干边等规则落地的入；需要「一步到位拿到铁证」的人，不妨再等等。

10.2 官方承认的缺口：医院在喊缺人

人才缺口不是培训机构编的卖点，是行业大会上的官方口径。2026 年的行业大会上，中国睡眠研究会理事长与北京大学人民医院睡眠中心主任都指出：医院人才培养滞后、学科体系碎片化；同期发布了《睡眠障碍与慢病"同防同治"行动倡议》（来源：新华网健康 2026 年 7 月 20 日报道）。两件事同场发生，含义清楚：头部的医院在呼吁补人，行业的行动倡议在推动体系化。

需求落在哪？结合第 8 章的建设潮看更清楚。2026 年半年里，疏勒、诸城、望江、陇南、宜昌五个县市级医院成建制建睡眠中心，单笔采购百万级——**中心建起来了，人从哪来？** 设备到位只要几个月，人才培养按年算。未来两三年，「会操作监测、会做筛查宣教、能撑起睡眠中心日常运营」的基层人才，是这条建设线的直接缺口。

落点具体有三个：基层筛查与门诊辅助人才（配合医生做初筛、宣教、随访）；睡眠中心的运营支持岗位（预约、设备管理、数据整理）；院外的健康管理服务岗（康养机构、社区、企业健康服务）。注意第三个落点——它不在医院围墙里，恰恰是新职业定位的主场：健康管理师管「健康」，不管「诊疗」，院外的空间比院内更大，也更对口。

10.3 想入行怎么学：挑培训与 AI 辅助学习法

先说挑培训。 认证未定型阶段，挑培训用五项检查清单，缺一项就降一档信心：

1. **办学方是谁？** 有无可查的行业背书——行业协会、医学院校、正规职业院校，还是查无此人的「研究院」。
2. **课程大纲覆盖什么？** 至少要有基础睡眠知识（睡眠生理、常见睡眠问题）与数据解读（看得懂手环数据和初筛报告），通篇销售话术课的直接排除。
3. **有没有真实服务或见习环节？** 只录播课不见服务的，学完等于没学——这个职业的核心能力在「服务」。
4. **收费与承诺的关系。** 收费透明、承诺克制（讲清楚「结业证书」的性质）的靠谱；「包过」「保就业」「全国通用证书」连发的，按陷阱对待。
5. **结业凭据是什么性质？** 培训结业证、团体标准的技能证、还是含糊其辞的「认证」——问清楚发证主体，自己在公开渠道查得到再交钱。

再说怎么学。 已经在学或已入行的人，AI 辅助学习三招。第一招，知识整理——把课程笔记交给大模型做结构化。给你一条可直接抄的：

```
你是一位学习助手。我在学习「睡眠健康管理」相关课程，下面是我整理的
课程笔记片段（可能有错漏）：

【笔记】（粘贴你的课堂笔记或课程材料摘录）

【任务】1）整理成结构化知识卡：概念 / 要点 / 常见误区 三栏；
2）指出笔记里前后矛盾或说不通的地方；
3）针对每个概念出 1 道自测问答题（附答案）。
```

【要求】只基于我给的笔记内容整理，不补充外部知识；不确定的地方标注「需核对教材」；输出 800 字以内。

第二招，模拟问答——让 AI 扮演服务对象做陪练（方法沿用第 9 章的模拟顾客三步：设定角色、你练应答、复盘改话术）。第三招，资料更新——用 AI 追踪标准与政策的动态，但记住第 2 章的时效边界：它说「最新政策」时，你要自己去官方渠道核。

三招共用的学习纪律一句话：**AI 是学习助手，不是知识来源。** 核心知识要回到教材与官方口径——认证未定型的阶段，你学的东西将来要接受正式体系的检验，根子上错的，到时候全部重学。

10.4 细分口：睡眠小城与康养文旅

主战场之外，两个细分口值得知道。

县域「睡眠小城」模式。广东陆河把睡眠健康产业写进了县级招商口径——县政府层面在推睡眠主题的康养产业（来源：陆河县政府网公开文章）。县域做睡眠，做的是「康养文旅」：睡眠主题的酒店、民宿、疗愈课程、健康旅游线路。这条线上要的人，是「懂睡眠服务 + 能做文旅运营」的复合型——健康管理师的课程背景加服务经验，正好对口。

城市侧的场景开放。深圳在社会福利领域开放 21 个应用场景测试，睡眠健康企业对接会有 24 家机构参会（来源：中国经营网报道）。对接会、场景测试这类动作说明：城市里的养老机构、社区服务、企业健康管理，都在往里装睡眠模块——养老机构里的睡眠监测与服务岗，是当下就能盯着的位置。

两个细分口有一个共同特征：**离「服务」近，离「医疗」远。**这恰好是新职业的定位主场——健康管理师的价值在健康促进与生活方式指导，不在诊疗。想清楚了这一点，选培训、选岗位的思路会清晰很多：你要攒的是服务案例，不是医疗资历。

动手练习

做一次真实的培训尽调。步骤：

1. 检索三个在售的「睡眠健康管理师」培训项目（搜索引擎或平台随手能搜到一堆），记下办学方、价格、学制、承诺。
2. 用 10.3 节的五项检查清单逐项打分（每项合格/不合格/查不到）。
3. 深挖一项：结业凭据的发证主体，去它的官方网站或公开渠道查一次——查得到主体、查得到证书性质的，记「合格」；只给宣传图不给可查主体的，记「不合格」。
4. 产出一份对比结论：三个项目各自的短板一句话。如果你的结论是「三个都不合格」，这本身就是本章最想教给你的判断力——再等等，不丢人。

思考题

1. 「方向确定、路径未定」——这个阶段的职业对什么样的人是机会、对什么样的人是坑？你自己属于哪一类？
2. 认证未定型阶段，「全国通用证书」的宣传为什么尤其可疑？等全国统一制度定型后，现在考的证会发生什么？
3. 10.2 节说「设备到位只要几个月，人才培养按年算」。这个时间差对医院、对从业者分别意味着什么机会？
4. 县域睡眠小城与城市养老场景，两个细分口你更适合哪一个？从你的现有技能出发说说理由。
5. 动手实操：完成 10.5 节的三项目尽调练习，把对比结论存档——半年后制度若有新进展，翻出来对照，你会看到自己判断力的变化。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	时间线图	新职业进展时间线：新职业工种（2025-07）→ 团体标准起草与培训导师出现 → 全国统一教材/学时制度（标注「未定型，待验证」）	自绘
图 10-2	清单卡	挑培训五项检查清单卡（办学方/大纲覆盖/见习环节/收费承诺/凭据性质），角标「缺一项降一档信心」	自绘
图 10-3	分布图	细分口机会分布：医院口（筛查/运营支持）· 县域口（睡眠小城/康养文旅）· 城市口（养老机构/场景测试），共同标注「离服务近、离医疗远」	自绘

第 11 章 底线与长期：数据隐私、合规与习惯

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：睡眠数据比步数敏感得多——它连着你的健康状态与作息规律，谁在收、收去哪、怎么删，你得心里有数，本章给隐私三原则；B 端从业者要守住合规两条线——对用户不作医疗建议、对宣传不写疗效承诺。走得远：AI 是工具，睡眠卫生的习惯才是根本，工具越多越要回到根本。章末收束全书：记录、看懂、该就医时就医——产业在变热、标准在收紧、AI 在进化，但个人要做的就这三件事。

11.1 最私密的数据：隐私三原则

先想一个问题：手环记录你的步数和记录你的睡眠，是一回事吗？不是。步数暴露的是「你今天走了多少路」，睡眠数据暴露的是「你几点睡、几点醒、夜里心率血氧什么样、有没有呼吸异常」——它能拼出你的作息规律和健康状态。这样的数据交给谁、存多久，值得你比对待购物记录认真得多。

三条原则，按顺序立：

原则一：本地优先。 能在设备或 App 本地完成的统计和查看，就不必上传。买设备前看一眼：这款产品的数据是不是必须联网存云端才能用？隐私政策里写明数据存储位置和期限的，比含糊其辞的可信。第 2 章说过「对话记录管理」那个设置，同样逻辑——花五分钟搞清楚你的数据在哪，比事后焦虑有用得多。

原则二：脱敏上传。 需要把数据交给 AI 分析时，按第 2 章的红线执行：身份信息不上传，健康指标给趋势和区间而不是原始逐秒数据。这条在本书出现已经第三次了，因为它是所有睡眠数据使用动作里唯一的一层主动防线。

原则三：定期清理授权。 每季度做一次「数据体检」：检查手机里每个睡眠相关 App 的授权（它还在读你的什么？）；翻一遍大模型应用的历史对话（该删的删）；想想哪些不用的 App 该卸载了——卸载前先看它有没有数据删除入口。授权是会积累的：半年前装的一个助眠 App，可能到现在还在读你的健康数据。

三原则的共同逻辑：**隐私不是「不给任何人看」，是「每一步都出于你的知情选择」**。完全不上云的设备功能有限，全裸上传又风险失控——中间那条线画在哪，应该由你画，而不是由 App 的默认设置画。

11.2 合规两条线：非医疗建议与不写疗效

写给 B 端读者，也写给所有在社群里转发过「助眠产品」的普通人。合规就两条线，每条线一个清单。

第一条线（C 端视角）：不把 AI 输出当诊疗意见。第 7 章的三个可信度层级是这条线的日常工具：睡眠卫生常识可以信，个人数据分析当参考，诊断治疗一律清零。把这条线内化的方法不是记条文，是养成一个习惯——每次 AI 给出具体的健康结论，先问自己一句「这个回答在第几层」。层对了，AI 是助手；层错了，助手变庸医。

第二条线（B 端视角）：宣传与话术不碰疗效。第 9 章的对照表（能说/不能说）直接拿来用，这里补三个延伸场景：直播带货时口播同样受约束，「根治」「治愈」四个字进了直播间也是广告；私域社群里的一对一推荐，同样不算「私人聊天豁免」——承诺疗效的聊天记录就是证据；转发供应商的宣传素材前，先用第 5 章的三类话术（无出处数据/医疗暗示/模糊认证）过一遍——上游违规，转发者共担。

还有一个容易踩的坑专门说：**产品资质如实表述**。智能床、睡眠监测设备里，哪些按医疗器械管理、注册备案信息是什么，以药监部门的查询为准——有就是有，没有就不说，不自我拔高。「医疗级」三个字，是资质决定的，不是营销部决定的。

两条线的共同方法论一句话：**把「能说的」与「不能说的」清单化，靠清单不靠记忆**。人在推介自家产品时天然会夸，这是人性不是品行问题——正因为靠不住记忆和自觉，才要把红线写成贴在柜台里的表、写进直播脚本的开头。

11.3 AI 依赖与睡眠卫生的回归

工具讲了一整本书，最后一节要把位置摆正：**工具之上，还有习惯**。

睡眠卫生的常识清单，你在这本书里见过多次：规律作息、睡前管理光线和屏幕、下午以后别碰咖啡因、卧室安静黑暗温度适宜。这些说法的出处是官方科普（全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》）和医生公开科普的通行口径。它们有两个特点：成本几乎为零；效果排在很多昂贵手段前面。一张几千块的智能床垫，替代不了晚上十一点的手机——这句话不是否定床垫，是给床垫找对位置。

AI 在这件事上的正确定位：**帮你发现「哪条习惯没做到」的模式，而不是替代习惯本身**。第 3 章的周度小结，价值在于让你看到「周三都睡得差，因为周三加班后喝咖啡」——看到模式的是 AI，改行为的是你。行为的改变没有任何工具能替你执行，这是全书的立场，也是这一节唯一想让你带走的话。

给一个自查标准：**如果你花在「管理睡眠数据」上的时间，超过了你为改善睡眠实际改变行为的时间，方向就反了。**翻一遍你手机上的睡眠 App：是三个以上吗？每天打开它们加起来超过十分钟吗？这些时间里有多少是在看数据、调设置、比分数，而不是在早睡？命中了，删两个 App，什么都不损失。

11.4 长期主义：记录、看懂、该就医时就医

收束全书。先把这三百页浓缩成三件事：

记录。手环坚持戴，睡眠日记坚持记（第 2 章模板二）。记录的意义不在单日数字，在于攒出你自己的基线——有基线，任何变化才看得出来。

看懂。手环数据会读（第 3 章），医院报告会读（第 4 章），宣传页会拆（第 5 章），App 会挑（第 6 章）。看懂不是成为专家，是不被糊弄——数据不吓你，话术不骗你。

该就医时就医。信号清单记牢（第 7 章），门诊找得到（政策已经把门诊铺到你所在的地市），就诊准备做得足（AI 整理、人工把关）。这一条排在第三，分量排第一。

三件事之外，交代一下你身处的这个时代背景：产业在变热——5737 亿的总盘、县医院的建设潮、头部厂商训练睡眠大模型；标准在收紧——国标实施、等级评定落地、补贴进场；AI 在进化——垂类大模型已落地，设备会越来越「懂你」。这个变化里的个人策略其实很稳：**变化的是工具，不变的是三件事**。手环换了几代，记录还是记录；App 层出不穷，看懂还是看懂；AI 再聪明，该就医时就医的判断还是你自己和医生的。

AI 在三件事里都有它的位置：帮你记（整理日记与周报）、帮你看懂（翻译术语与数据）、帮你准备（就诊材料与提问清单）。但每一章你都见过同一句话的变体——AI 管数据整理与初筛建议，人管生活习惯与就医决策。决定和行动，始终是你自己的。

睡好觉这件事，说到底不复杂：今晚比昨晚早睡二十分钟，胜过这一章剩下的所有字。

动手练习

给自己定一份「季度数据体检」清单，并让它跑起来：

1. 列清单：本机所有睡眠相关 App（含大模型应用）逐一过——授权了什么、历史对话删不删、还用不用；手环云端数据怎么导出和删除，找到入口。
2. 执行一遍，记录耗时。第一次可能要半小时，之后会越来越快。
3. 在日历上设一个下季度同日的重复提醒，标题就叫「数据体检」。
4. 顺手做一件事：把第 3 章的睡眠趋势档案更新到最新——季度边界正好是看趋势的好节点。

思考题

1. 睡眠数据和步数数据，敏感度差在哪？用「能拼出一个人的什么画像」来回答。
2. 「清单化合规」为什么比「记住规矩」可靠？结合你自己的一次「知道不该做还是做了」的经历说明。
3. 11.3 节的自查标准里，你命中了几条？如果一条都没命中，说说你的使用习惯里最值得保持的一条。
4. 记录、看懂、就医三件事，哪一件对你最难？难的点在时间、习惯还是观念？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习，把体检清单存档并设好季度提醒——这本书教的方法，从今天起进入你的日程表，才算真的读完。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	示意图	隐私三原则：本地优先（数据尽量在设备端）/脱敏上传（身份不上传、指标给区间）/定期清理授权（季度体检），中间标「每一步出于知情选择」	自绘
图 11-2	对照图	合规两条线：C 端「不把 AI 输出当诊疗意见」（三层级角标）+ B 端「不写疗效承诺」（能说/不能说表角标），合流标注「清单化，靠清单不靠记忆」	自绘
图 11-3	收束图	全书三件事收束：记录（手环+日记）→ 看懂（数据/报告/宣传页）→ 该就医时就医（信号清单+门诊），AI 标注为三件事的帮手而非替代	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 2 章 · 模板一：解读手环睡眠周报。适合第 3 章的场景，先在这里建立用法。
- 第 2 章 · 模板二：整理睡眠日记。医生问诊时最爱问「最近睡得怎么样」，多数人答不上来。让 AI 帮你把零散记录整理成
- 第 2 章 · 模板三：拆解一张产品宣传页。第 5 章选购避坑的预热。
- 第 4 章 · 方法上，报告先做结构化摘录：把关键数字抄成一张小表（别拍整页照投喂，一是上下文长度装不下，二是原始报告上
- 第 6 章 · 五问的答案散在商店介绍、隐私政策、订阅条款里，自己逐条翻效率低。把材料收集起来，让通用大模型帮你按框架填
- 第 7 章 · 三，提问清单。 让 AI 帮你生成，人工筛到 5 条以内。提示词：
- 第 9 章 · 对应的「翻译」工作可以让 AI 帮你做。给你一条可直接抄的提示词：
- 第 10 章 · 再说怎么学。 已经在学或已入行的人，AI 辅助学习三招。第一招，知识整理——把课程笔记交给大模型做结构化

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-02 ｜ 检索通道：钱面/政策检索经豆包搜索 MCP 完成，检索词与命中如实记录于调研卡（07-批三调研/79-睡眠经济.md）纪律：全书行业数据仅来自本清单所列来源；来源缺失或未能核实处，正文一律标注「待验证」。

一、政策文件与官方行动

1. 《健康中国行动 2024—2026 年实施方案》睡眠健康促进专项行动、2026 世界睡眠日主题「优质睡眠 美好生活」、超 3 亿人睡眠困扰与 18 岁以上困扰率 48.5% 口径——新华日报交汇点报道（2026-03-21）：http://jsnews.jschina.com.cn/jsyw/202603/t20260321_s69be0316e4b03734d4022b83.shtml
2. 国家卫健委为民服务八件实事「每个地市至少一家医院提供心理门诊、睡眠门诊」（2025）——陆河县政府网招商文引用口径：http://www.luhe.gov.cn/luhe/jjlh/lhyw/content/post_1258061.html
3. 全国爱卫办《睡眠健康核心信息及释义》发布与委级在线访谈解读（2025-04）——国家卫健委在线访谈页：https://www.nhc.gov.cn/wjw/zxft/hdjl_zxft_detail.shtml?id=191919328e254c35b54173b453079147
4. 「睡眠健康管理师」列为国家新职业工种（2025-07，培训认证体系起步、全国统一教材/学时制度未定型【待验证】）——同上陆河县政府网引用口径：http://www.luhe.gov.cn/luhe/jjlh/lhyw/content/post_1258061.html
5. 中国首个《智能床》国家标准（2025-08 实施，舒达为主要起草单位之一）、家具智能等级评定标准 L1-L4（2026-03 落地）——中国质量新闻网（2026-09-08）：https://www.cqn.com.cn/jiajujiancai/content/2026-09/08/content_9171834.htm
6. 智能床纳入多地购新补贴（深圳 2025 适老化焕新：睡眠监测产品 30% 补贴、单人最高 1 万元）——央广网（2026-09-24）：https://tech.cnr.cn/techgd/20260924/t20260924_527823600.shtml
7. 深圳 AI 终端行动计划（2025-2026：2026 年产业规模 8000 亿、60 个典型应用场景含智慧养老）；深圳社会福利 21 个应用场景开放测试、睡眠健康企业对接会 24 家参会——中国经营网：https://www.cet.com.cn/xwsd/10486820.shtml

二、政府采购公开记录（2026-05～2026-10）

1. 新疆疏勒县医院睡眠中心设备采购，中标 293 万元+（明细部分打码），2026-09-17，重复经颅磁刺激仪、睡眠呼吸初筛仪、多导睡眠记录仪、脑电治疗仪、心理沙盘等 11 类：https://m.bidcenter.com.cn/news-4-442909980.html
2. 诸城市人民医院睡眠中心设备采购，中标 170.39 万元，2026-10-10：https://www.chinamae.com/purchases/4979b682007ac6ec212befb120ca08ae.html
3. 望江县医院睡眠中心建设设备采购，中标 140 万元，2026-08-12，含经颅磁刺激仪等：https://aqggzy.anqing.gov.cn/bid_dydetail.html?categoryNum=003002013&infoid=5a64ba3e-7386-4207-863e-b08fe6bdbae9&typecode=1592c435-3825-4c0e-94c9-e8c182d5c028
4. 陇南市武都区中心医院睡眠中心设备采购，中标 103.56 万元，2026-06-24，多导睡眠测量仪、便携睡眠监测仪等：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260624_26801785.htm
5. 宜昌某医院睡眠中心设备采购，金额公告中打码，2026-05-08，多导睡眠记录仪 1 台、失眠治疗仪 1 台、睡眠呼吸记录仪 4 台：https://m.bidcenter.com.cn/news-4-417920509.html

（金额完整的 3 单合计约 607 万元，均为医疗侧。）

三、行业资料与产业公开动作

1. 慕思牵头东莞市数字人体与智慧睡眠创新联合体（2026-07 揭牌）、睡眠垂类大模型 T12 落地、联合华南理工/北航/北大三院等——新华网家居（2026-07-27）：http://www.xinhuanet.com/jiaju/20260727/75c8a2716e274e0d8ac331f020d10ba5/c.html
2. 慕思 2026 上半年 AI 产品收入 2.36 亿元、同比 +95.69%------华安证券研报（东方财富研报页）：https://data.eastmoney.com/report/zw_stock.jshtml?encodeUrl=iFS4V5lYZKK265TIMXRo+lmS8FSAJcbxyMw5FbVgVzs=
3. 《睡眠障碍与慢病”同防同治”行动倡议》发布；中国睡眠研究会理事长与北大人民医院睡眠主任指出医院人才培养滞后、学科体系碎片化（2026 大会）——新华网健康（2026-07-20）：http://www.xinhuanet.com/health/20260720/5abe6bae5ec84dd381a87c4d91138642/c.html
4. 《2026 中国优质睡眠白皮书》（10 家医药连锁联合发布，「店员专业能力待提升」列三大痛点之一）——央视网财经（2026-08-15）：https://business.cctv.com/2026/08/15/ARTI78VPsAhC8ZuH7YgMFug4260814.shtml
5. 智能床垫 2026 年约 45 亿元市场、科技助眠品类同比增速 90%（尚普咨询/艾媒咨询口径）——转引自中国质量新闻网（同节一第 5 条 URL）
6. 睡眠经济行业总盘 5737 亿元（2025，艾媒咨询口径）——调研卡产业面记录（豆包搜索命中，具体报告页未逐条留痕，引用时标注「行业研究口径」）

7. 喜临门更名「健康睡眠科技」并与清华共建联合研究中心、舒达 AI DREAM 独立品牌——调研卡产业面记录（豆包搜索命中，公开报道）

竞品书目（调研卡竞争面）

书名	出版社	年份/ISBN	定价
《深睡开关：一键重启一夜好眠》（沙建军）	清华大学出版社	2026-08，ISBN 9787302723097	69 元
《高效睡眠：让睡好觉成为简单的事》（李艳主编）	人民卫生出版社	2025-02，ISBN 978-7-117-37533-7	69.8 元
《DK 睡个好觉》	中国科学技术出版社	2026-03，ISBN 978-7-110-11171-0	—
《中国睡眠研究报告》（喜临门睡眠研究院主编）	社会科学文献出版社	2024-03，ISBN 9787522833330	118 元

（《AI 晚安电台的睡前陪伴》为科技人文故事集，非实用书——燕山大学图书馆著录：https://opac.ysu.edu.cn/mspace/searchDetailLocal/m4817a8540c50507d1a813dc17b92f031 ）

四、课件素材（本书第 2 章改编来源，本地资产）

1. 《AI 入门课程》——培训资料/01_通用课程/01-AI 入门/AI 入门课程.pptx（另有 AI 入门课程-气象.pdf/pptx 变体）：基础原理、主流模型、使用边界部分
2. 《AI 大模型进阶课》——培训资料/01_通用课程/02-文本大模型/AI 大模型进阶课.pptx：与 AI 更好交流的方法、提示词骨架（角色/任务/背景/要求四要素）
3. 改编约定：仅取通用 AI 方法论框架，睡眠场景示例（睡眠周报解读/睡眠日记整理/宣传页拆解）全部为本书原创

检索与写作说明

- 全书数据检索截至 2026-11-02；调研卡（07-批三调研/79-睡眠经济.md）为唯一行业数据真源，本清单为其来源映射。
- 未能核实的口径（睡眠健康管理师全国统一认证制度、部分行业报告原始页面）已在正文标注「待验证」或按「行业研究口径」引用，未作确定化处理。
- 涉及健康判断的内容（就医信号等）采用医生公开科普通行口径，仅作就医提醒参考；本书不提供医疗建议。



milulab.com/books/ai-sleep-health/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu